



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KEGIATAN

KOMITE MUTU RS. PRIMA HUSADA SUKOREJO

TRIWULAN II TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54,

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU TRIWULAN II RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2025

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Sukorejo, 30 Juni 2025

Telah Disetujui Oleh :

Direktur PT. Disa Prima Medika

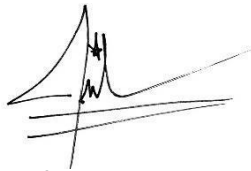


(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Kegiatan Komite Mutu Triwulan II Tahun 2025
Rumah Sakit Prima Husada

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Komite Mutu RS. Prima Husada



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP., CHAE)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan II Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada bulan berikutnya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Triwulan II Tahun 2025. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN 1

DAFTAR ISI 1

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 1.2 Tujuan 1

 1.2.1 Tujuan Umum 1

 1.2.2 Tujuan Khusus 1

BAB II 2

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU 2

TRIWULAN II TAHUN 2025 2

 2.1 Kegiatan Pokok 2

 2.2 Kegiatan yang Dilakukan 3

 2.3 Jadwal Kegiatan 3

 2.4 Pencatatan dan Pelaporan 3

BAB III 4

HASIL KEGIATAN 4

 3.1 Pemantauan Indikator Mutu 4

 3.1.1 Indikator Mutu Nasional 4

 3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional 5

 3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 21

 3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo . 24

 3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit 39

8. MATERNITAS 50

9. PONEK 52

10. NEONATOLOGI 53

11. ICU 54

12. RADIOLOGI 55

13. LABORATORIUM 56

14. REHAB MEDIS 57

15. FARMASI 57

16. GIZI 58

17. REKAM MEDIS 59

18. LIMBAH – K3RS 59

19. SDM 60

20. KESEKRETARIATAN 61

21. DRIVER 61

22. PEMULASARAAN JENAZAH 61

23. ATEM – IPSRS 61

24. LAUNDRY 62

25. CSSD	62
26. CLEANING SERVICE	63
27. KEAMANAN	64
28. GUDANG UMUM	64
29. PPI	64
30. PKRS.....	65
31. ASURANSI CENTER	66
32. HUMAS & MARKETING	66
33. CSO	66
34. MOD-MPP-PIPP	67
35. TB di IRJA.....	67
36. KEUANGAN	67
37. TIM HIV	68
38. KB	68
39. STUNTING	68
40. IT - SIM RS.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi RS Prima Husada Sukorejo adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi RS Prima Husada Sukorejo, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat, (2) mengutamakan kepuasan pasien, (3) meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien RS Prima Husada Sukorejo melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan di semua unit kerja untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dari KARS STARKES berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikannya indikator rumah sakit sebagai berikut : Indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Rumah sakit (IMP-RS) yang meliputi : indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem dan indikator terkait manajemen resiko, kemudian yang ketiga yakni indikator mutu prioritas unit.

Identifikasi prosedur, proses dan hasil dari kegiatan yang dinilai sebelumnya pada tahun 2024, disertai tujuan untuk menekan permasalahan yang ada di rumah sakit mendasari dipilihnya indikator baru di indikator prioritas. Kriteria pemilihan tetap didasarkan pada kasus yang memiliki volume tinggi, resiko tinggi atau biaya tinggi, disesuaikan dengan visi dan misi rumah sakit. Laporan Komite Mutu Triwulan II Tahun 2025 indikator mutu yang diambil oleh unit kerja.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di setiap unit di RS Prima Husada Sukorejo

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi peningkatan mutu RS Prima Husada Sukorejo melalui pemantauan indikator mutu internal atau eksternal berdasarkan standar Komite Mutu Tahun 2022
2. Mengevaluasi program keselamatan pasien dengan pemantauan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKP-RS)
3. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu lain, yang dilakukan oleh unit terkait dengan peningkatan mutu yakni :
 - a. Program manajemen resiko
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja
4. Menganalisis capaian indikator mutu unit untuk mendapatkan bahan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut perbaikan di unit

BAB II
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU
TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Kegiatan Pokok

Seperti yang dijelaskan di atas, kegiatan pemantauan indikator mutu Komite Mutu Tahun 2025 yang dilaporkan adalah periode Triwulan II Tahun 2025. Adapun indikator mutu yang dipantau adalah sebagai berikut:

A) Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit
6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit
7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00
8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit
9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
12. Keterlambatan Respon Terhadap Komplain
13. Kepuasan Pasien

B) Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien
 - b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR
 - c. Kepatuhan Pengembalian Obat Sisa Anestesi & Narkotika ke Ruang Farmasi
 - d. Kepatuhan Pelaksanaan *Surgical Safety Checklist* (SSC)
 - e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi
 - f. Kepatuhan Kebersihan Tangan
 - g. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Ketepatan pemberian MgSO₄ Pada Pasien PEB
 - b. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS
 - c. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.
 - d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium.
 - e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
 - f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol
 - g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA_{1c} $<7\%$
 - h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
 - i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
 - j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis
3. Indikator Berdasarkan Renstra RS
 - a. Kepuasan pasien
4. Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi
 - b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO
 - c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi
5. Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran
 - b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal
6. Praktik Klinis yang Di Evaluasi (17 Diagnosis yang di evaluasi)
 - 1) CVA
 - 2) Batu Ureter
 - 3) Diabetes Millitus

-
- 4) GEA
 - 5) HIV
 - 6) Hipertensi
 - 7) TB
 - 8) Keganasan (Ca Mammae)
 - 9) Pneumonia
 - 10) SC
 - 11) Partus Normal
 - 12) PEB
 - 13) BPH
 - 14) Hydronefrosis
 - 15) PPOK
 - 16) Fraktur terbuka
 - 17) Stroke hemoragik
 - 18) Stroke Trombosis

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan analisis hasil capaian mutu indikator di unit kerja
3. Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian atau mencapai target yang ditentukan
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu di unit kerja
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu di unit kerja secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu (dilakukan setiap bulan)
3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator di unit kerja setiap bulan, serta menyusun program perbaikan mutu dengan teknik PDSA oleh penanggungjawab penggumpul data unit di koordinasikan dengan komite Mutu
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap satu bulan.
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo dengan hasil banchmarking perbandingan capaian mutu dengan RS lain setiap tiga bulan sekali.

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab data mutu unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab. Data hasil pemantauan ditulis pada form laporan harian mutu dan dilakukan validasi kepada kepala unit untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan valid. Jika data sudah valid selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mencari rencana tindak lanjut bagi indikator mutu yang masih belum mencapai target atau standar yang ditetapkan. Hasil pengolahan dan analisis data dituangkan dalam laporan tertulis kemudian akan dilaporkan kepada penanggungjawab mutu rumah sakit setiap bulan dalam rapat koordinasi mutu bulanan.

Penanggung jawab mutu Rumah Sakit selanjutnya akan menentukan langkah untuk membuat rencana tindak lanjut indikator mutu yang belum sesuai targert sebagai bentuk feedback dari pelaporan penanggung jawab mutu di unit.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu

Berikut merupakan hasil pemantauan indikator mutu RS. Prima Husada Sukorejo yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025.

3.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2025.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

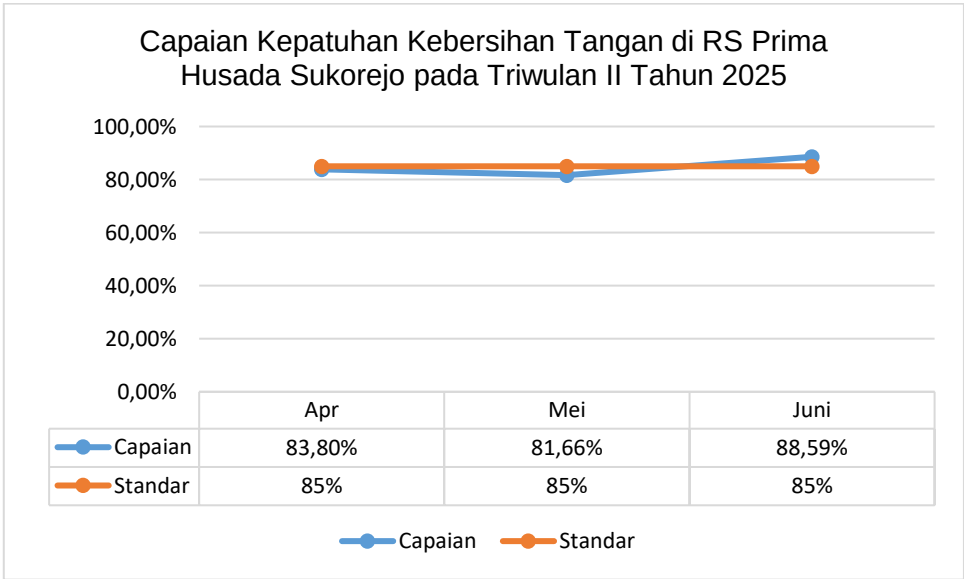
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Triwulan II Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		April	Mei	Juni			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80%	81,66%	88,59%	≥85%	84,68%	PDSA
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	97,92%	98,07%	93,83%	100%	96,61%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,65%	99,73%	98,97%	100%	99,45%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	96,77%	85,71%	100%	≥80%	94,16%	Dipertahankan
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	74,78%	70,14%	79,70%	≥80%	74,87%	PDSA
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	4,52%	1,37%	3,84%	≤5%	3,24%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	71,19%	74,97%	77,96%	≥80%	74,71%	PDSA
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Ket
		April	Mei	Juni			
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	98,44%	98,84%	98,75%	≥80%	98,68%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	97,44%	97,99%	98,75%	100%	98,06%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥76.61%	96,10%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan



Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II (April–Juni), diperoleh rata-rata sebesar 84,68%. Pada bulan April, tingkat kepatuhan mencapai 83,80%, kemudian menurun menjadi 81,66% di bulan Mei, dan meningkat signifikan menjadi 88,59% di bulan Juni. Meskipun nilai masih berada di atas 80%, capaian belum memenuhi standar ideal kepatuhan kebersihan tangan WHO yaitu ≥ 85%. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan II Tahun 2025

Problem	Kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II 2025 hanya mencapai 84,68%, belum mencapai target ≥85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.

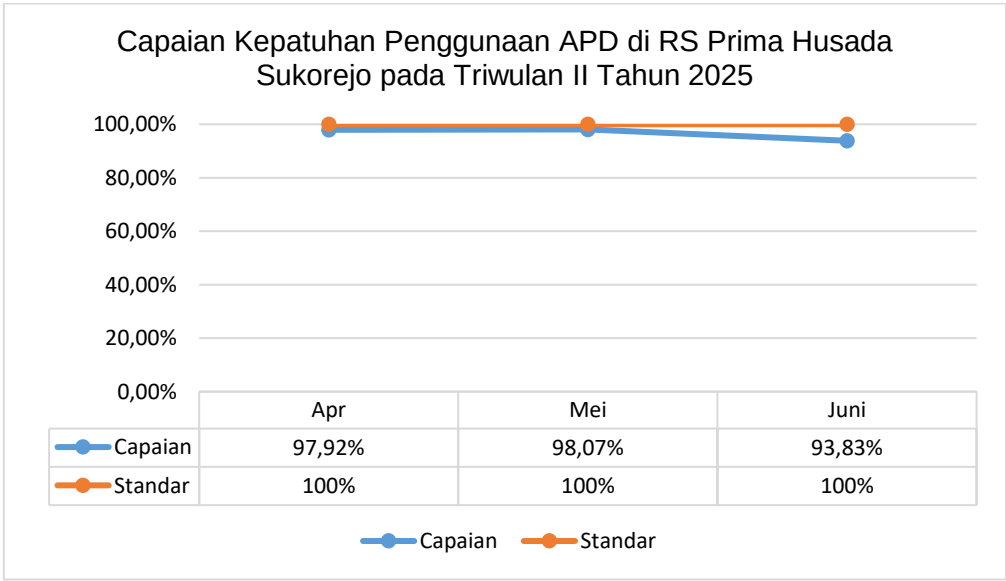
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 84,68%. - Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. - Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. - Tujuan: - Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli–September 2025). - Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen pelayanan - Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	- IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu - Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. - Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan II 2025 yaitu 84,68% - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah IRNA 3A sebesar 84,68%. - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 90,43% walaupun belum mencapai standar - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan - Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40% - Sebelum Tindakan aseptik sebesar 49,07% - Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37% - Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88% - Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53%
Action	- Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentas i hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/m inggu /unit (Juli–Sept 2025)

2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap minggu ke manajemen	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Juli–Des 2025)

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:
Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Triwulan II yakni mencapai 96,61% masih belum mencapai target 100% yang telah ditetapkan sebagai standar rumah sakit. Capaian tertinggi terjadi pada bulan Mei 98,07%. Capaian terendah terjadi pada bulan Juni 93,83%. Terdapat tren penurunan dari Bulan Mei ke Juni sebesar 4,24%

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100% yakni 96,61%.
---------	---

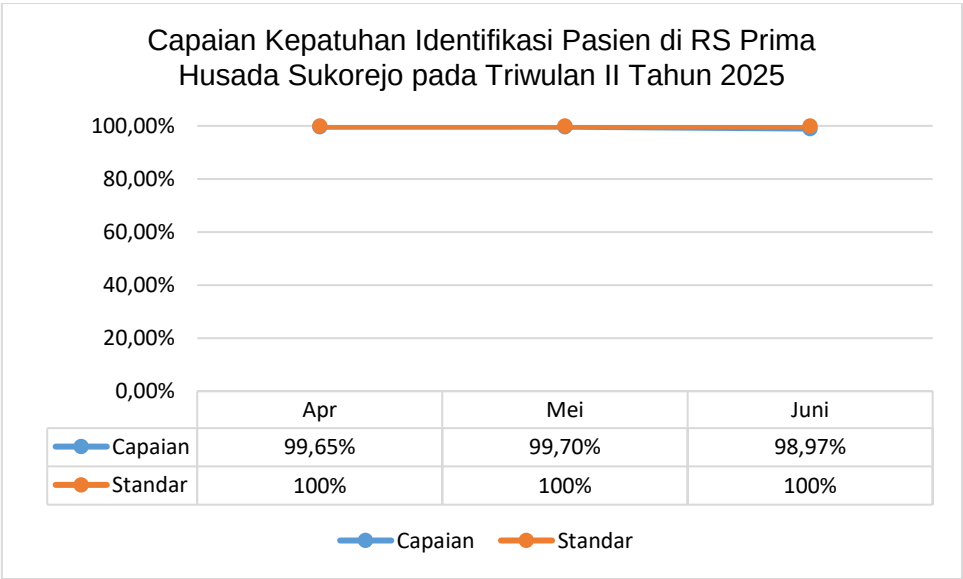
	Meskipun pelatihan penggunaan APD telah dilaksanakan pada bulan Mei (untuk seluruh staf) dan diperkuat kembali dalam pelatihan PMKP bulan Juni (khusus CS dan Unit Umum), tingkat kepatuhan penggunaan APD masih belum mencapai target 100%.
Step	Melakukan penguatan edukasi berkelanjutan dan monitoring langsung kepada seluruh staf, khususnya kepada kelompok yang sudah mendapatkan pelatihan (CS dan Unit Umum), serta mempersiapkan strategi intervensi berikutnya untuk staf penunjang dan pelayanan melalui pelatihan terjadwal di bulan Juli 2025.
Plan	- Masalah yang ditemukan: - Kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan APD belum mencapai target 100%, dengan rata-rata kepatuhan 96,61%. - Setelah dua kali pelatihan (umum dan khusus), masih ditemukan staf (terutama CS dan non-medis) yang belum konsisten dalam penggunaan APD sesuai prosedur. - Rencana pelatihan berikutnya untuk staf penunjang dan pelayanan akan dilakukan pada bulan Juli 2025. - Tujuan: - Meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD hingga mencapai 100%, khususnya pada unit yang telah mendapatkan pelatihan. - Mempersiapkan intervensi lanjutan untuk unit yang akan mengikuti pelatihan di bulan Juli (penunjang dan pelayanan). - Rencana Aksi: - Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai tindak lanjut pelatihan. - Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. - Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. - Merancang pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan di bulan Juli, dengan pendekatan berbasis kasus.
Do	- Melakukan observasi langsung terhadap penggunaan APD staf CS dan Unit Umum pasca pelatihan - Memberikan feedback dan pembinaan langsung kepada staf yang ditemukan tidak sesuai prosedur. - Menyusun materi pelatihan berbasis risiko kerja untuk unit penunjang (Laboratorium, Radiologi, Farmasi, Gizi) dan pelayanan (IGD, Rawat Inap, OK) sebagai persiapan pelatihan Juli.
Study	- Rata-rata capaian kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 96,61% belum mencapai target 100% - Ketidaksesuaian ditemukan terutama pada: - Petugas CS masih ditemukan menggunakan satu sarung tangan saat membuang limbah ke TPS. - Perawat masih menggunakan handscoon di luar prosedur, misalnya saat membawa troli dari nurse station ke ruang pasien. - Beberapa petugas CS tidak memakai sarung tangan saat mengambil sampah di unit pelayanan. - Petugas laboratorium tidak mengenakan gown saat pengambilan sampel, meskipun berada di area berisiko. - Perawat tidak menggunakan APD lengkap saat melakukan tindakan aseptik, seperti pemasangan infus atau perawatan luka. - Monitoring menunjukkan unit yang mendapat pelatihan (CS & Umum) lebih aware, namun perubahan perilaku belum konsisten. - Evaluasi pelatihan menunjukkan perlunya penguatan praktik langsung dan coaching on the spot, bukan hanya teori.
Action	- Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN untuk deteksi dini ketidakpatuhan - Melaksanakan audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum sebagai

	tindak lanjut pelatihan. 3. Menyusun dan membagikan SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan petugas non-medis di area kerja masing-masing. 4. Meningkatkan peran Karu dan supervisor untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian harian. 5. Merancang pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan di bulan Juli, dengan pendekatan berbasis kasus
--	--

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana a	Wakt u
1	Audit langsung dan coaching on-site oleh IPCN/IPCLN	Mendeteksi dini ketidakpatuhan dan memberikan pembinaan langsung	Seluruh unit pelayanan, penunjang, CS, dan Unit Umum	• Observasi langsung • Pembinaan di tempat (real-time coaching) • Dokumentasi dan tindak lanjut langsung	IPCN, IPCLN	Juli
2	Audit dan supervisi khusus bagi staf CS dan Unit Umum	Menindaklanjuti hasil pelatihan Juni dan memperkuat penerapan di lapangan	Petugas CS dan Unit Umum	• Audit mingguan • Supervisi oleh IPC dan Karu • Penguatan budaya kerja aman	IPCN, Karu, Supervisor CS, Koordinator Unit Umum	Juli
3	Penyusunan dan distribusi SPO singkat penggunaan APD untuk CS dan Non-Medis	Menyediakan panduan praktis dan mudah dipahami di area kerja	Bidang Umum, (CS, Keamanan, Gudang, Sopir)	• SPO 1 lembar disesuaikan dengan risiko kerja • Poster visual dipasang di area kerja • Sosialisasi singkat per shift	Tim IPC, Tim PMKP, Kepala Unit	Juli
4	Peningkatan peran Karu dan supervisor dalam monitoring harian	Memastikan keberlanjutan kepatuhan di level unit	Seluruh unit pelayanan, penunjang, dan umum	• Format pelaporan ketidaksesuaian harian • Peningat briefing harian • Koordinasi antar shift	Kepala Ruang	Juli
5	Pelatihan khusus penggunaan APD untuk staf penunjang dan pelayanan berbasis kasus	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan penggunaan APD berdasarkan situasi kerja	Petugas laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rawat inap, IGD	• Pelatihan berbasis studi kasus nyata • Diskusi interaktif • Simulasi langsung	Tim Diklat, IPCN/IPC LN, PMKP, Komite PPI	Juli

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II 2025 mencapai 99,45%. Dari 18698 petugas yang diidentifikasi, 18594 petugas patuh terhadap Identifikasi pasien sedangkan 104 petugas tidak patuh dalam identifikasi pasien. Capaian 99,45% menunjukkan komitmen tinggi tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien, khususnya identifikasi pasien dengan dua identitas sebelum tindakan. Namun, capaian ini belum mencapai target standar 100%, sehingga tetap perlu perhatian dan perbaikan. Capaian tertinggi yakni di Bulan Mei (99,70%) dan capaian terendah yakni di Bulan Juni (98,97%), Sebanyak 104 kejadian ketidakpatuhan tercatat. Meski terlihat kecil secara persentase, setiap insiden ketidakpatuhan dapat berdampak serius, termasuk risiko tertukarnya identitas pasien dan kesalahan pemberian tindakan atau obat

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan II Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,45%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : - Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponak - Kepatuhan identifikasi pasien selama Triwulan II menunjukkan penurunan pada bulan Juni, meskipun telah dilakukan pelatihan PMKP untuk staf unit umum pada bulan tersebut. Nilai kepatuhan belum mencapai standar maksimal 100%. Akar Masalah yang teridentifikasi : - Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP - Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual - Petugas non-medis (umum) mulai menunjukkan peningkatan kesadaran pasca pelatihan, namun belum diikuti oleh bagian pelayanan dan penunjang. - Sosialisasi hasil pelatihan belum menjangkau seluruh staf karena keterbatasan waktu dan rotasi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : - Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 - Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh IPCN dan Tim Mutu untuk memantau dampak pelatihan. - Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.

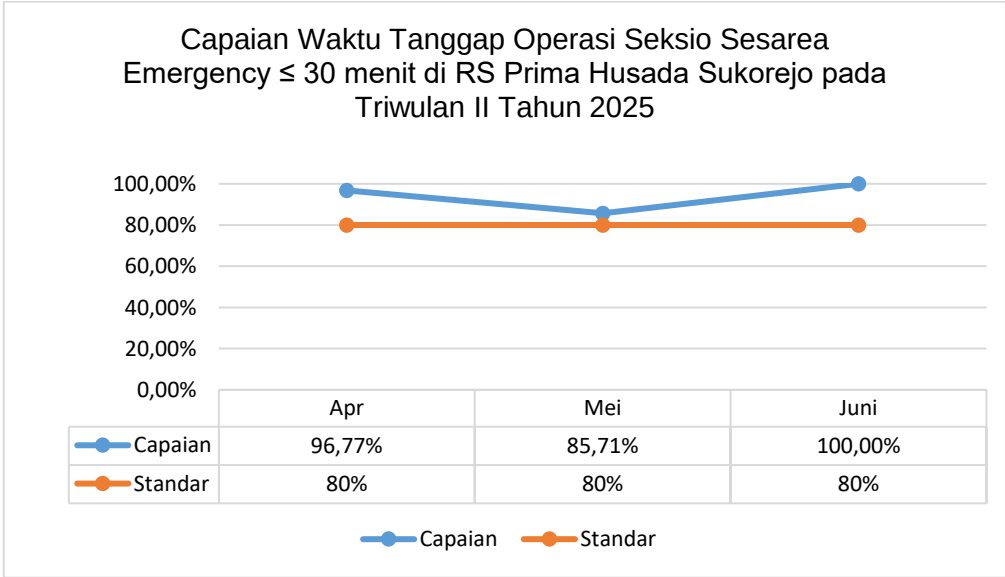
	d. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
Do	1. Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien 2. Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh 3. Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). 4. Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	1. Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponak 2. Capaian bulan April–Mei relatif tinggi dan stabil. 3. Capaian bulan Juni menurun menjadi 98,97% karena: a. Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual di Rawat Inap b. Perubahan kebiasaan memerlukan waktu untuk tertanam, terutama pada petugas baru dan unit dengan beban tinggi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 99,45%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 2. Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan. 3. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. 4. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025	Meningkatkan pemahaman dan implementasi identifikasi pasien yang benar sesuai standar akreditasi	Petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, laboratorium, radiologi, farmasi, dll)	Pelatihan tatap muka atau daring, disertai simulasi kasus dan roleplay	Tim PMKP, IPCN/IPCL N, Komite Keperawatan/Medis, SDM	Bulan Juli
2	Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan	Menilai dampak pelatihan terhadap praktik identifikasi pasien di lapangan	Unit pelayanan dan penunjang pasca pelatihan	Observasi langsung, audit checklist, wawancara petugas	Tim Mutu, Tim SKO Karu/	Bulan Juli, Agustus, September
3	Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.	Menyediakan panduan praktis yang mudah diakses dan dipahami oleh petugas	Petugas umum, pelayanan, dan penunjang	Cetak SPO ringkas dan pasang di titik strategis (nurse station, ruang tindakan, dll)	SKP, Kepala Unit	Bulan Juli
4	Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit	Menjamin kesiapan teknis pelatihan agar berjalan efektif	Seluruh peserta dari unit pelayanan	Identifikasi peserta, pembuatan materi,	Tim PMKP, SDM, Kepala	Bulan Juli

	pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli	dan tepat sasaran	dan penunjang	jadwal, dan undangan	Unit masing-masing	
--	--	-------------------	---------------	----------------------	--------------------	--

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit

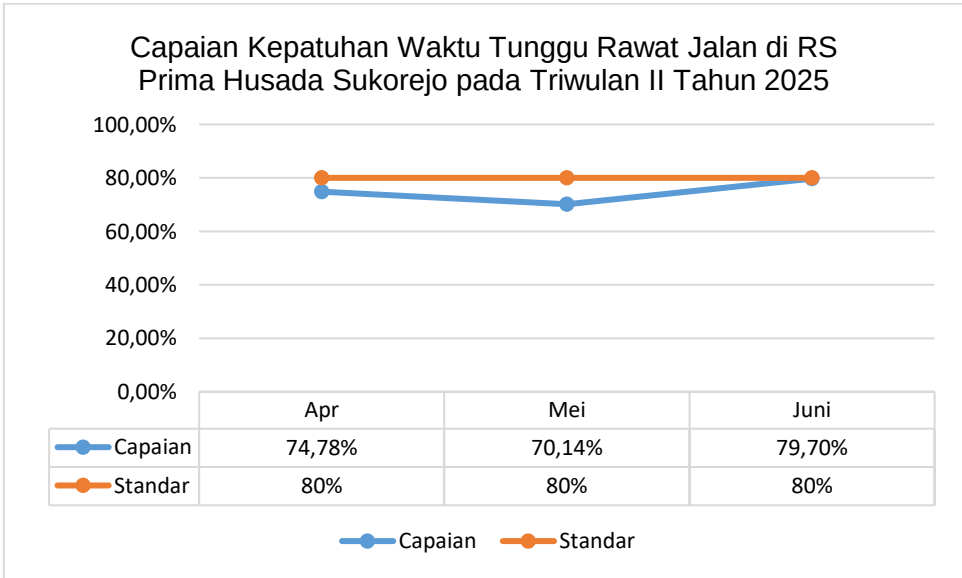


Gambar 3.5. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar yakni dengan rata-rata 94,16%. Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dan tindakan kurang dari 30 menit, sehingga operasi dilakukan secara tepat.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.6. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025 mecapai 74,87%. Nilai ini masih berada

di bawah standar yang ditetapkan, yaitu $\geq 80\%$. Capaian terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 70,14%, sementara capaian tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 79,70%. Meskipun terdapat perbaikan pada bulan Juni, hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan belum sepenuhnya memenuhi target mutu, sehingga diperlukan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan dalam sistem dan proses pelayanan.

Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit pada Triwulan II Tahun 2025

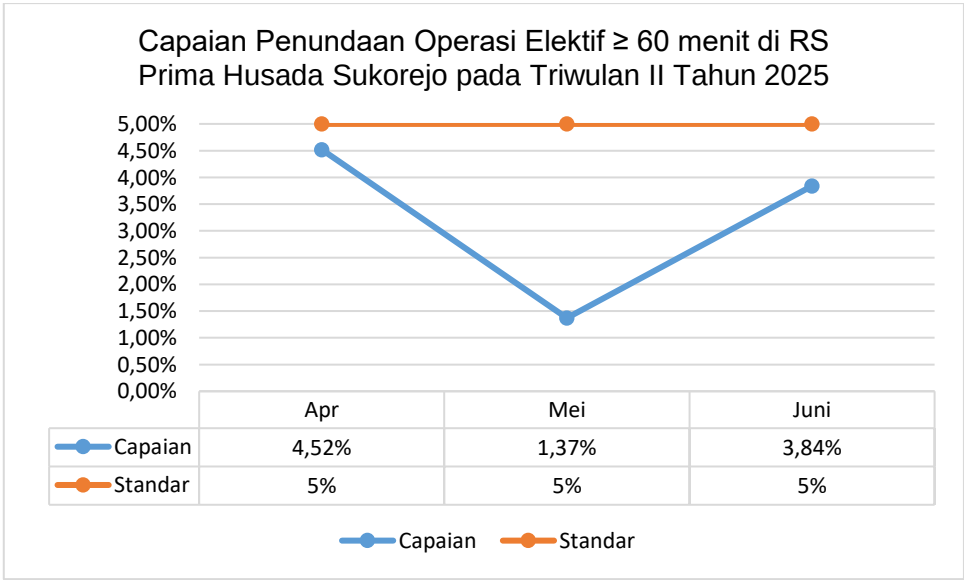
Problem	Rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 74,87% dan belum mencapai target 80%. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan yakni 1 jam 09 menit jauh melebihi standar 60 menit.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu tunggu rawat jalan
Plan	Masalah yang ditemukan : Rata-rata waktu tunggu rawat jalan masih tinggi, yakni 1 jam 09 menit, dengan tingkat kepatuhan terhadap standar waktu tunggu ≤ 60 menit hanya sebesar 74,87%. Tujuan : Meningkatkan persentase kepatuhan standar waktu tunggu ≤ 60 menit menjadi minimal 80% pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi: 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Memonitor waktu kedatangan dokter dan jumlah pasien menumpuk di awal waktu praktik. 2. Melakukan edukasi kepada seluruh petugas front office dan pendaftaran tentang pentingnya efisiensi waktu tunggu.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan rata-rata capaian waktu tunggu rawat jalan Bulan Triwulan II yakni 74,87% belum mencapai $\geq 80\%$. 2. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan di poli yakni 1 jam 09 menit. Ini dikarenakan: a. Penumpukan Pasien di Awal Jam Poli b. Beberapa dokter spesialis tidak datang tepat waktu sesuai jadwal praktik yang telah ditentukan,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Berdasarkan rata-rata capaian dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit yakni 74,87% belum mencapai $\geq 80\%$. Rata-rata keterlambatan terjadi dalam waktu 1 jam 09 menit. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Penjadwalan pasien berbasis slot waktu per jam agar kedatangan pasien lebih tersebar dan tidak terpusat di awal waktu praktik. 2. Monitoring ketepatan waktu kedatangan dokter secara harian dan pemberian teguran atau evaluasi bagi yang tidak disiplin. 3. Edukasi pasien melalui call center/pendaftaran online untuk datang sesuai waktu yang ditentukan.

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Penjadwalan ulang atau pembagian tugas pasien di poli untuk DPJP	Meningkatkan pemerataan pasien per DPJP dan mengurangi waktu tunggu	Pasien rawat jalan di poli spesialis	- Review kuota pasien per DPJP - Penjadwalan slot waktu per dokter	Komite Medik, Koordinator Poli	Satu bulan
2	Monitoring kedatangan dokter dan evaluasi disiplin waktu praktik	Mengurangi waktu tunggu awal poli	Dokter Poli Rawat Jalan	Rapat koordinasi dengan Kabid Pelayanan & Komite Medik	Kabid Pelayanan & Komite Medik	Satu bulan

3	Edukasi pasien untuk datang sesuai jadwal melalui call center/pendaftaran online	Meningkatkan kedisiplinan waktu kedatangan pasien sesuai slot waktu	Pasien rawat jalan	- Petugas call center memberi reminder jam kedatangan saat reservasi - Edukasi saat konfirmasi jadwal online	Pendaftaran & CSO	Satu bulan
---	--	---	--------------------	---	-------------------	------------

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit

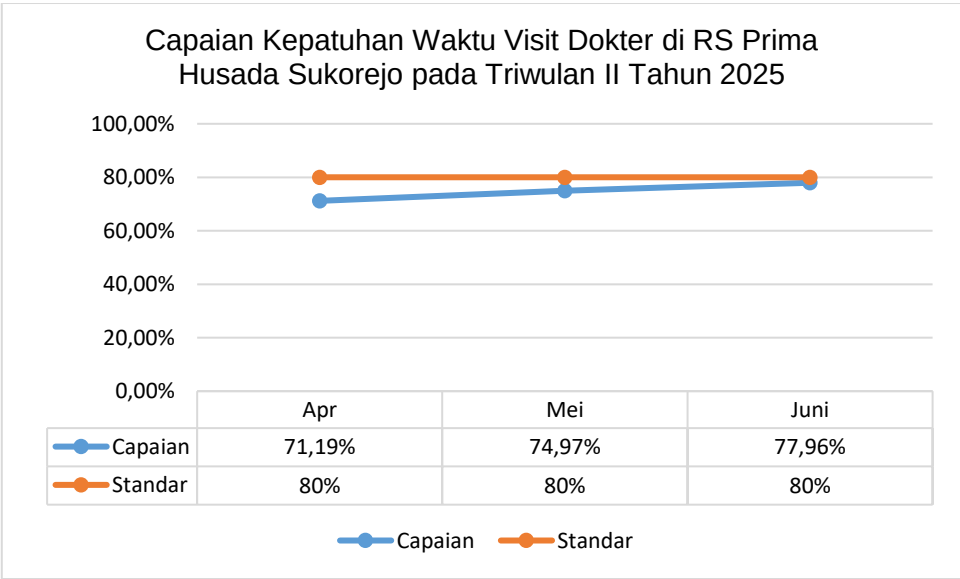


Gambar 3.7. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025.

Hasil Capaian :

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II tahun 2025 yakni 3,24%. Capaian ini sudah mencapai standar <5%.

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.8. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap mencapai 74,71% dan masih dibawah standar $\geq 80\%$.. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah dokter spesialis yang belum melakukan visite pasien secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan jam kerja rumah sakit dan standar pelayanan medik. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis, pelaksanaan terapi, dan perencanaan pemulangan pasien.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Triwulan II Tahun 2025

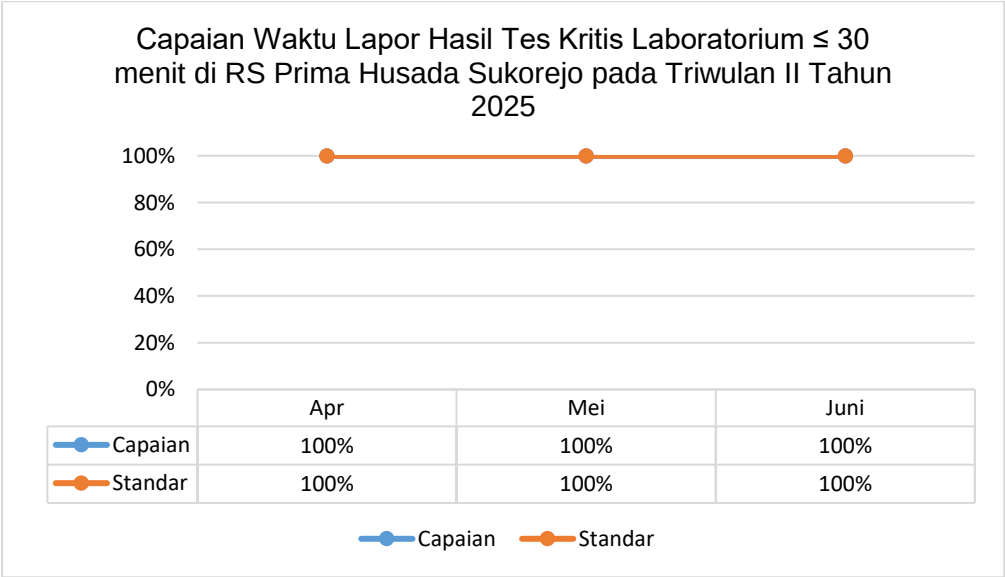
Problem	Rata-rata capaian waktu visite dokter pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 74,71% belum mencapai target $\geq 80\%$
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk waktu visite dokter
Plan	Identifikasi Masalah : - Capaian kepatuhan waktu visit dokter spesialis masih di bawah standar (rata-rata Bulan Triwulan II yakni 74,71%. - Adanya dokter spesialis juga bekerja di tempat lain (RS lain, klinik, dll) pada jam 06.00–14.00 WIB. - Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif. Tujuan : - Meningkatkan kepatuhan visit dokter menjadi minimal 80%. Rencana Aksi: - Audit harian oleh kepala ruangan - Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter - Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). - Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis
Do	Apa pengamatan yang dilakukan? - Pelaksanaan Visit Rutin Sesuai Jam yang Ditentukan (Pagi $\leq$ 14.00 WIB) - Waktu visit dicatat dalam rekam medis dan checklist visit. - DPJP mengisi form/checklist visit dengan tanda tangan/paraf sebagai bukti kunjungan.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 74,71%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Ini dikarenakan: Rata-rata dokter visite yang lebih dari 14.00 WIB memiliki jadwal praktek di Rumah Sakit lain sehingga jadwal di RS Prima Husada Sukorejo lebih dari jam 14.00 WIB

	2. Terdapat dokter yang cuti, tapi pengganti hanya oleh dokter jaga (bukan DPJP definitif). 3. Adanya Pasien yang berada di ICU sebagian besar mengalami kondisi terminal sehingga pasien tersebut berada dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan segera.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan rata-rata capaian pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 74,71%. Ini dapat disimpulkan bahwa waktu visite dokter spesialis belum mencapai $\geq 80\%$. Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Audit harian oleh kepala ruangan 2. Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter 3. Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat). 4. Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Audit harian oleh kepala ruangan	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Dokter yang datang ≥ 14.00	Rapat koordinasi dengan komite medik	Kepala Ruang	Satu bulan
2	Koordinasi dengan pihak Kabid Pelayanan, SDM dan Komite Medik terkait DPJP yang tidak melakukan visitasi ke pasien sehingga mempengaruhi OPPE dokter	Meningkatkan kepatuhan dokter dalam memvisite pasien	Seluruh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di rumah sakit	Rapat Koordinasi dengan SDM	Komite Medik & SDM	Satu bulan
3	Menetapkan pengganti resmi DPJP saat cuti (harus ditunjuk & tercatat)	Menjamin kontinuitas pelayanan medis melalui penggantian DPJP saat cuti	Dokter Penanggung jawab Pasien	Menetapkan DPJP pengganti resmi saat dokter cuti, dan mendokumentasikannya secara formal.	Kepala Bidang Pelayanan	Satu bulan
4	Peningkatan koordinasi antar tim ICU dan DPJP serta prioritasasi pasien kritis	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter spesialis pada pasien rawat inap khususnya pasien kritis di ICU melalui sistem koordinasi dan prioritasasi yang lebih baik.	Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan pasien kritis yang dirawat di ICU	• Menyusun daftar harian pasien kritis yang membutuhkan prioritas visite. • Melaksanakan koordinasi pagi antara perawat ICU dan DPJP sebelum jam visite	Kepala Ruang ICU, DPJP, Komite Medi	Satu bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit

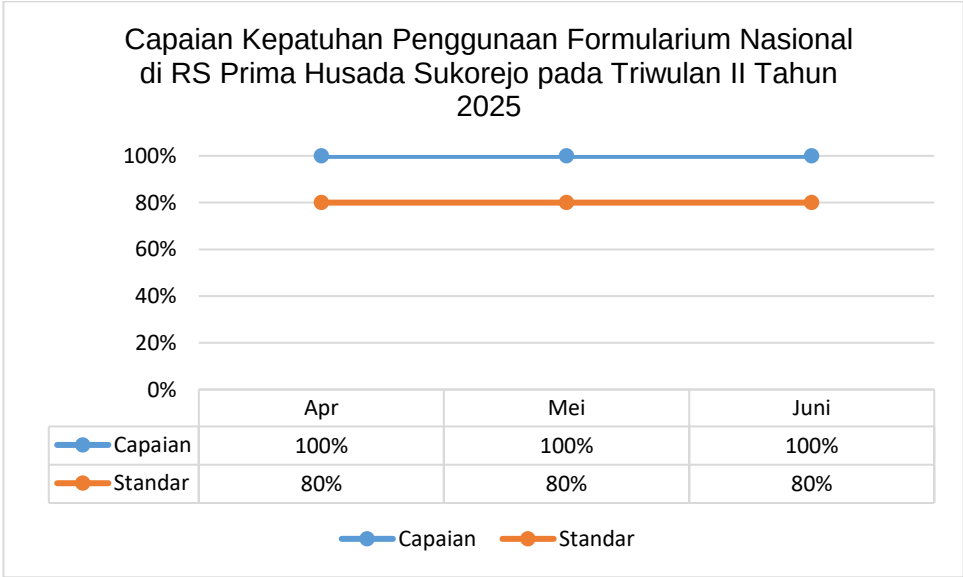


Gambar 3.9. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

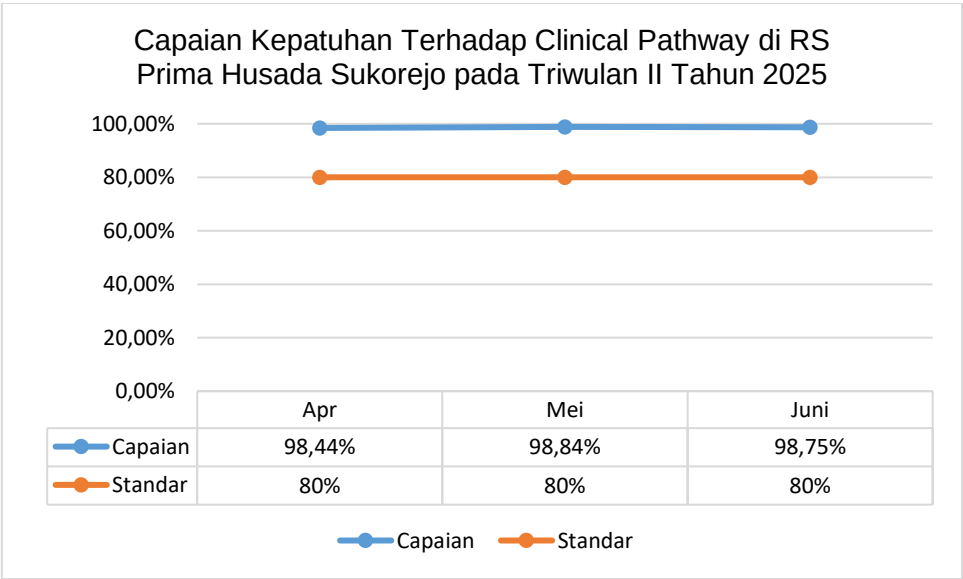


Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar yakni 100%. Dari formularium nasional yang diobservasi, Seluruh resep yang diberikan oleh Unit Farmasi menggunakan obat yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas). Capaian 100% menunjukkan bahwa tidak ada peresepan obat di luar Fornas, sehingga risiko penggunaan obat tidak sesuai standar dapat ditekan.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

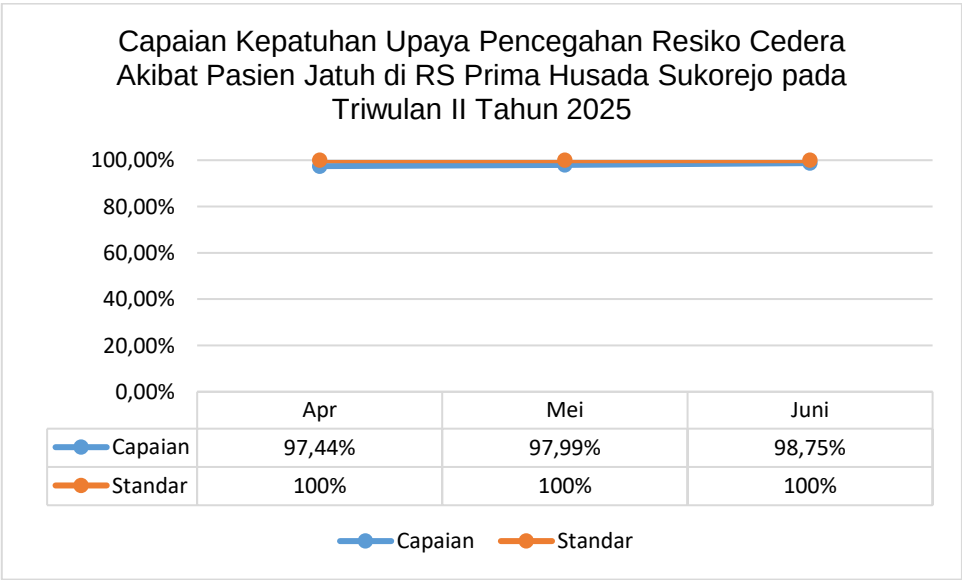


Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai standar 80%. Capaian kepatuhan terhadap *clinical pathway* Bulan Triwulan II Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 98,68%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Triwulan II didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Normal, Seksio Cesarea, Curretage General & Curretage Regional.

11.Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Terdapat tren peningkatan capaian dari bulan ke bulan, yaitu dari 97,44% (April) menjadi 98,75% (Juni). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kepatuhan secara bertahap selama triwulan berjalan.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

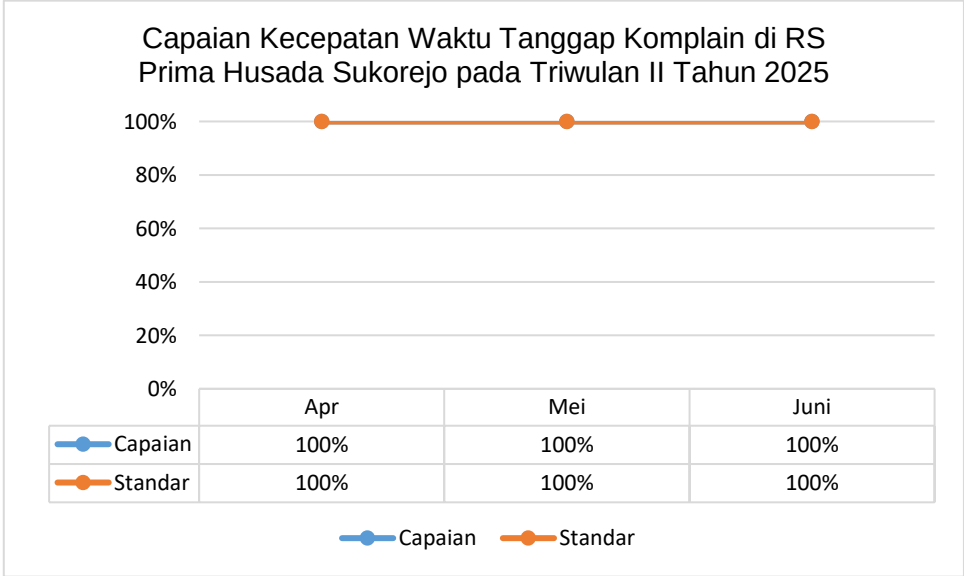
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah : 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni 2025, belum seluruh petugas di unit pelayanan dan penunjang terpapar materi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrining awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrining ulang pasien indikasi risiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak terempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,06% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan staf dalam pencegahan risiko jatuh	Seluruh petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, lab, radiologi,	Pelatihan klasikal dan simulasi lapangan terkait skrining dan tindakan pencegahan risiko jatuh	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli

	dan penunjang		farmasi, rehab medik, dll)			
2	Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami	Menyederhanakan panduan agar mudah diikuti dan konsisten diterapkan di semua unit	Seluruh petugas yang mengisi skrining risiko jatuh	Meninjau SPO lama dan menyusun ulang SPO singkat berbasis praktik terbaik dan hasil audit	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli
3	Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien	Meningkatkan kesadaran petugas dan keluarga pasien tentang pencegahan risiko jatuh	Seluruh pasien rawat inap dan petugas di ruang perawatan	Pemasangan stiker/peringatan visual pada dinding/tempat tidur pasien dengan risiko jatuh	Kepala Unit	Juli
4	Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentas	Meningkatkan identifikasi pasien risiko tinggi dan memastikan dokumentasi lengkap	Pasien dengan risiko jatuh dan petugas yang melakukan penilaian risiko	Distribusi label risiko jatuh & audit checklist kelengkapan form risiko jatuh	Kepala Unit	Juli

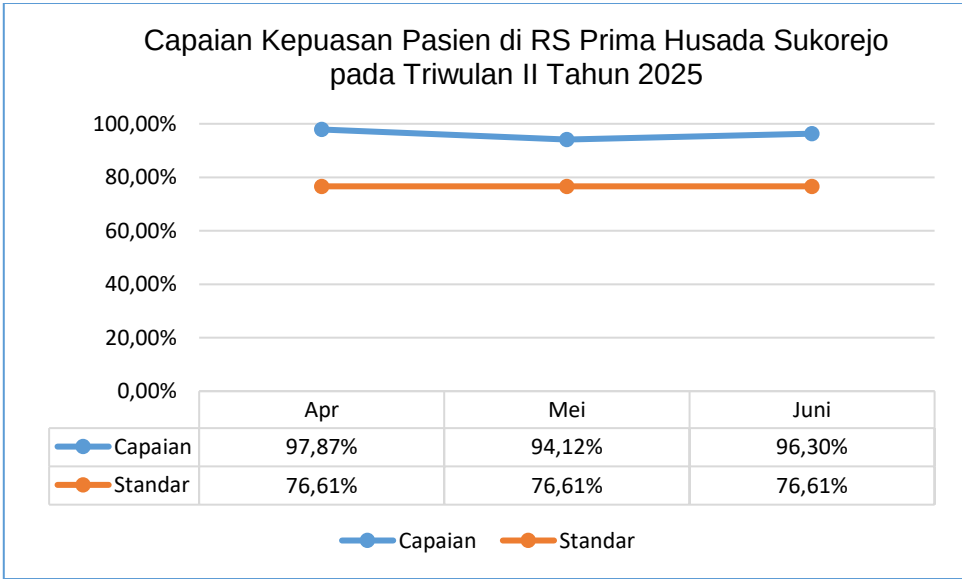
12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain



Gambar 3.13. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian:
Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Triwulan II Tahun 2025 yakni 100% dan sesuai standar. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 96,10%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada bulan Triwulan II, capaian tetap berada jauh di atas standar, yang menunjukkan kualitas pelayanan tetap terjaga.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,65%	99,70%	98,97%	100%	99,68%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,40%	97,67%	97,56%	100%	97,54%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada Obat Sisa Anestesi

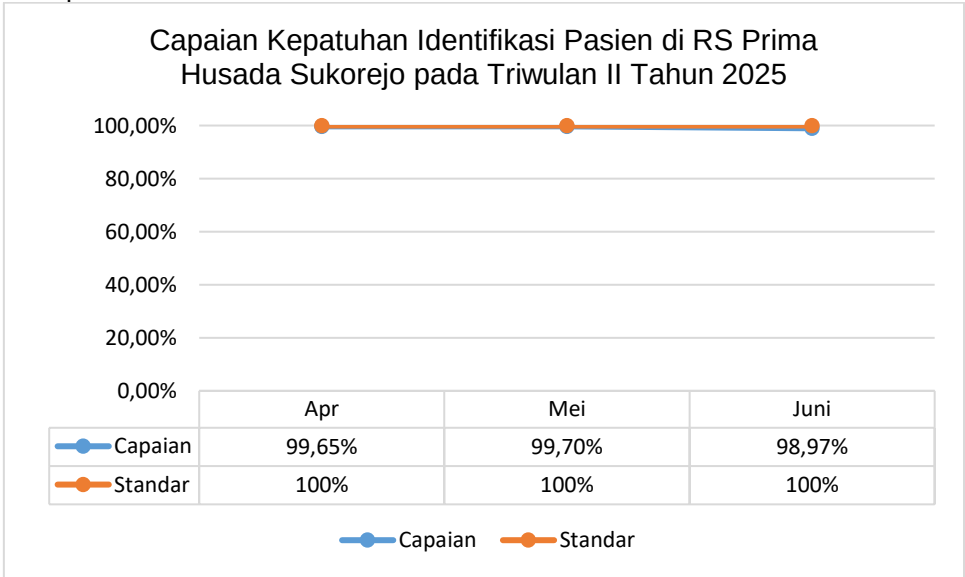
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
		(High Alert Medications): a. Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi						
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		b. Kejadian tidak dilakukannya penandaan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80%	81,66%	88,59%	100%	84,68%	PDSA
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan risiko pasien jatuh	97,92%	97,99%	98,75%	100%	98,06%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		2. Kepatuhan penanganan bronchopneumonia sesuai dengan kriteria klaim BPJS	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
		3. Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan				≥ 90%		Belum diisi

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
		dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.						
		4. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu $\leq$ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				$\geq 95\%$		Belum diisi
		5. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				$\leq 5\%$		Dipertahankan
		6. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				$\geq 95\%$		Belum diisi
		7. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $< 7\%$				$\geq 70\%$		Belum diisi
		8. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				$\geq 95\%$		Belum diisi
		9. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		Belum diisi
		10. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $< 140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				$\geq 75\%$		Belum diisi
3	Renstra RS	1. Kepuasan pasien	97,87%	94,12%	96,30%	$\geq 76,61\%$	96,61%	Dipertahankan
4	Perbaikan Sistem	1. Kejadian ketidaksesuaian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
			April	Mei	Juni			
		diagnose pre dan post operasi						
		2. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO	100%	99,79%	100%	100%	99,93%	PDSA
		3. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	1. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
		2. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II 2025 mencapai 99,45%. Dari 18698 petugas yang diidentifikasi,

18594 petugas patuh terhadap Identifikasi pasien sedangkan 104 petugas tidak patuh dalam identifikasi pasien. Capaian 99,45% menunjukkan komitmen tinggi tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien, khususnya identifikasi pasien dengan dua identitas sebelum tindakan. Namun, capaian ini belum mencapai target standar 100%, sehingga tetap perlu perhatian dan perbaikan. Capaian tertinggi yakni di Bulan Mei (99,70%) dan capaian terendah yakni di Bulan Juni (98,97%), Sebanyak 104 kejadian ketidakpatuhan tercatat. Meski terlihat kecil secara persentase, setiap insiden ketidakpatuhan dapat berdampak serius, termasuk risiko tertukarnya identitas pasien dan kesalahan pemberian tindakan atau obat

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

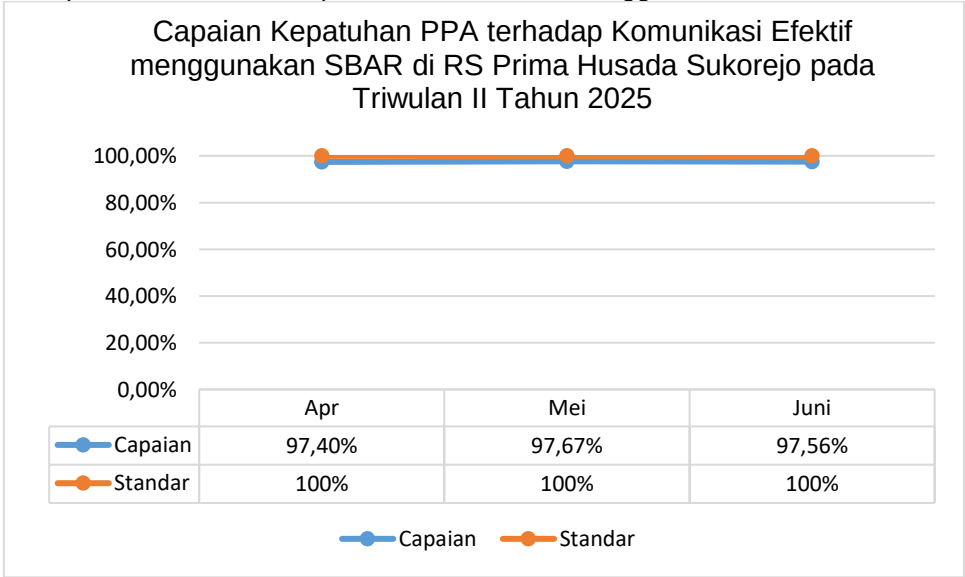
Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Triwulan II Tahun 2025 adalah belum mencapai target 100% yakni 99,45%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Masalah yang ditemukan : - Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponak - Kepatuhan identifikasi pasien selama Triwulan II menunjukkan penurunan pada bulan Juni, meskipun telah dilakukan pelatihan PMKP untuk staf unit umum pada bulan tersebut. Nilai kepatuhan belum mencapai standar maksimal 100%. Akar Masalah yang teridentifikasi : - Kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur identifikasi pasien dua langkah, yaitu tidak melakukan identifikasi secara visual maupun lisan sesuai SOP - Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual - Petugas non-medis (umum) mulai menunjukkan peningkatan kesadaran pasca pelatihan, namun belum diikuti oleh bagian pelayanan dan penunjang. - Sosialisasi hasil pelatihan belum menjangkau seluruh staf karena keterbatasan waktu dan rotasi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien di seluruh unit menjadi 100% dalam satu bulan. Rencana Aksi : - Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 - Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh IPCN dan Tim Mutu untuk memantau dampak pelatihan. - Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. - Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
Do	- Rekap nama staff yang tidak patuh dalam identifikasi pasien - Melakukan penjadwalan untuk koordinasi dengan individu yang tidak patuh - Sosialisasi dan Re-edukasi seluruh petugas tentang pentingnya identifikasi pasien dua langkah (visual dan lisan). - Supervisi langsung harian oleh kepala ruangan
Study	- Berdasarkan data capaian kepatuhan identifikasi pasien, terdapat 7 unit yang belum mencapai standar 100%, yaitu IRNA 2A, IRNA 2B, IRNA 3A, IRNA 3B, Maternitas, ICU dan Ponak - Capaian bulan April–Mei relatif tinggi dan stabil. - Capaian bulan Juni menurun menjadi 98,97% karena: - Proses identifikasi hanya dilakukan secara lisan tanpa konfirmasi visual di Rawat Inap - Perubahan kebiasaan memerlukan waktu untuk tertanam, terutama pada petugas baru dan unit dengan beban tinggi
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? - Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada Triwulan II tahun 2025 mencapai 99,45%, masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan identifikasi pasien. Follow-Up dan Rencana Lanjutan - Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025 - Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan.

	3. Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum. 4. Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli.
--	--

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan dan Sosialisasi untuk bagian pelayanan dan penunjang akan dilaksanakan di Bulan Juli 2025	Meningkatkan pemahaman dan implementasi identifikasi pasien yang benar sesuai standar akreditasi	Petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, laboratorium, radiologi, farmasi, dll)	Pelatihan tatap muka atau daring, disertai simulasi kasus dan roleplay	Tim PMKP, IPCN/IPCL N, Komite Keperawat an/Medis, SDM	Bulan Juli
2	Melakukan observasi lapangan dan audit mendadak oleh Tim SKP untuk memantau dampak pelatihan	Menilai dampak pelatihan terhadap praktik identifikasi pasien di lapangan	Unit pelayanan dan penunjang pasca pelatihan	Observasi langsung, audit checklist, wawancara petugas	Tim Mutu, Tim SKO Karu/	Bulan Juli, Agustus, September
3	Menyebarkan SPO singkat identifikasi pasien di area kerja unit umum.	Menyediakan panduan praktis yang mudah diakses dan dipahami oleh petugas	Petugas umum, pelayanan, dan penunjang	Cetak SPO ringkas dan pasang di titik strategis (nurse station, ruang tindakan, dll)	SKP, Kepala Unit	Bulan Juli
4	Mempersiapkan materi dan daftar peserta pelatihan PMKP untuk unit pelayanan dan penunjang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli	Menjamin kesiapan teknis pelatihan agar berjalan efektif dan tepat sasaran	Seluruh peserta dari unit pelayanan dan penunjang	Identifikasi peserta, pembuatan materi, jadwal, dan undangan	Tim PMKP, SDM, Kepala Unit masing-masing	Bulan Juli

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 97,54%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Problem	Rata-Rata Persentase Angka Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR mencapai 97,54%.
Step	Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Plan	1. Identifikasi Masalah: Tingkat kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) terhadap penggunaan komunikasi efektif dengan format SBAR belum mencapai standar 100%. Hasil monitoring menunjukkan adanya variasi dalam penerapan, terutama pada bagian <i>Assessment</i> dan <i>Recommendation</i>, yang sering tidak lengkap atau tidak sesuai format. 2. Tujuan: Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap penggunaan komunikasi SBAR hingga mencapai 100% pada seluruh unit pelayanan, khususnya pada proses serah terima pasien dan komunikasi antar-profesi 3. Rencana Aksi: a. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. c. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. d. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap

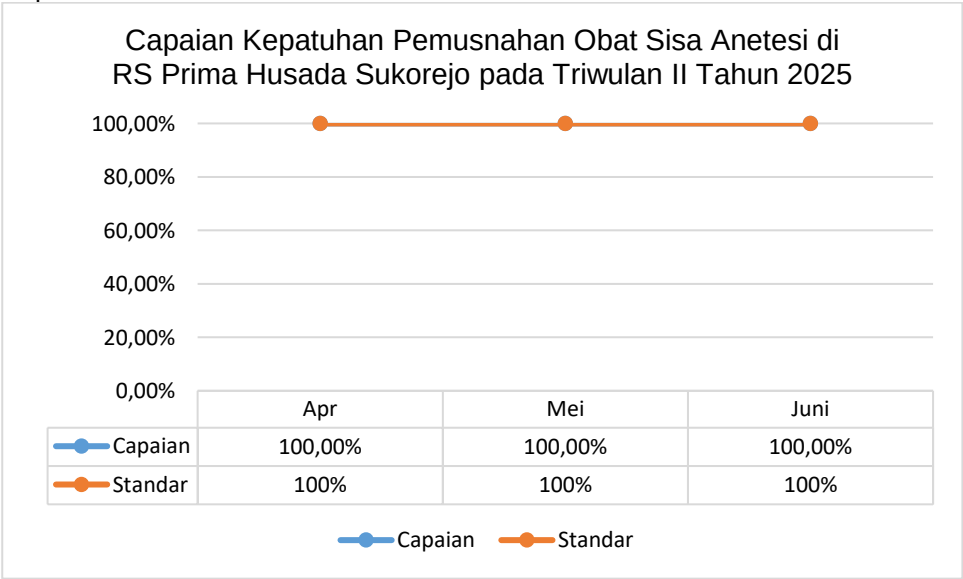
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni 97,54%. meskipun angkanya tergolong tinggi capainnya masih dibawah standar 100% Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan peningkatan supervisi pelaksanaan komunikasi SBAR secara rutin oleh Tim PKRS dan Tim Mutu. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi. 3. Menyediakan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis. 4. Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap
---------------	--

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Supervisi Pelaksanaan Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya.	Supervisi, pemberian umpan balik langsung dan edukasi singkat kepada petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	PKRS, Tim SKP, dan Tim Mutu	1 minggu
2	Monitoring dan evaluasi berkala oleh Kepala Unit Rawat Inap untuk menilai kelengkapan dan konsistensi penggunaan SBAR dalam dokumentasi serta praktik komunikasi	Meningkatkan kepatuhan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi efektif SBAR secara konsisten dan lengkap, guna menunjang keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.	Seluruh PPA (perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain) di unit rawat inap dan unit pelayanan lainnya	Monitoring dan evaluasi petugas saat ditemukan ketidaksesuaian	Kepala Ruangan	1 bulan

3	Penyediaan contoh-contoh SBAR yang baik di link sebagai panduan praktis	Meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pelaksana asuhan (PPA) dalam menggunakan format komunikasi SBAR melalui akses mudah terhadap contoh-contoh praktik baik (best practice) yang tersedia secara digital.	Seluruh PPA (perawat, bidan, tenaga medis) di seluruh unit pelayanan, khususnya yang melakukan serah terima pasien, komunikasi antar shift, dan komunikasi antar profesi.	Menyusun beberapa contoh SBAR yang baik dan lengkap yakni dalam bentuk dokumentasi tertulis	Tim SKP, PKRS	1 bulan
4	Feedback langsung kepada staf yang tidak mengisi dengan lengkap	Memberikan pembinaan dan perbaikan langsung kepada tenaga kesehatan yang tidak mengisi form SBAR secara lengkap	Seluruh tenaga kesehatan (perawat, bidan, atau tenaga lainnya) yang form SBAR tidak lengkap dan pengisian SBAR tetapi tidak terdokumentasi dengan benar	1. Menunjukkan bagian yang tidak terisi dan jelaskan dampaknya terhadap keselamatan pasien. 2. Berikan contoh pengisian yang benar dan arahkan untuk perbaikan ke depan	Tim SKP, PKRS	1 bulan

c. Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi

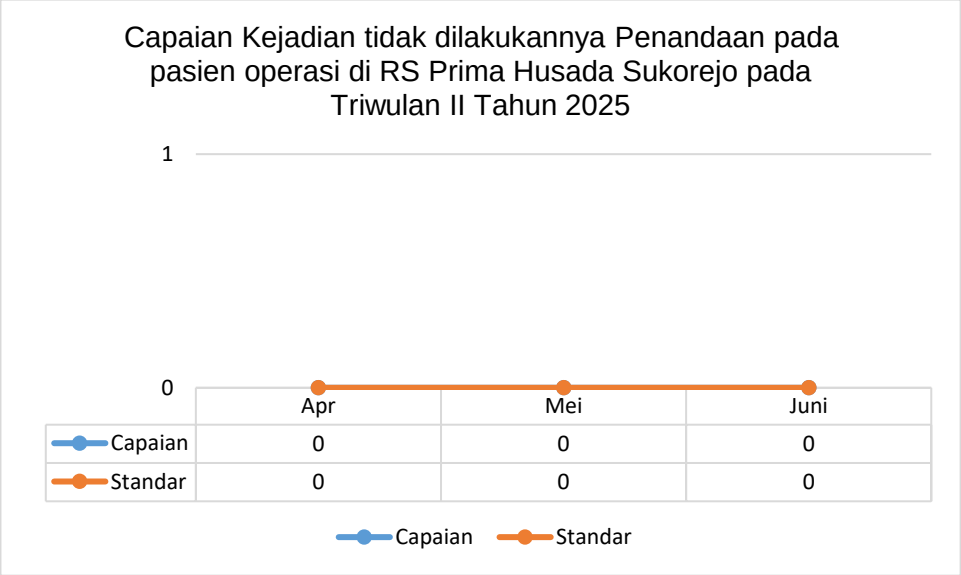


Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi di RS Prima

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemusnahan obat sisa anestesi di rumah sakit sudah berjalan sesuai prosedur, dan kontrol terhadap risiko penyalahgunaan obat-obatan anestesi sudah diterapkan secara maksimal.

d. Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Safety Checklist

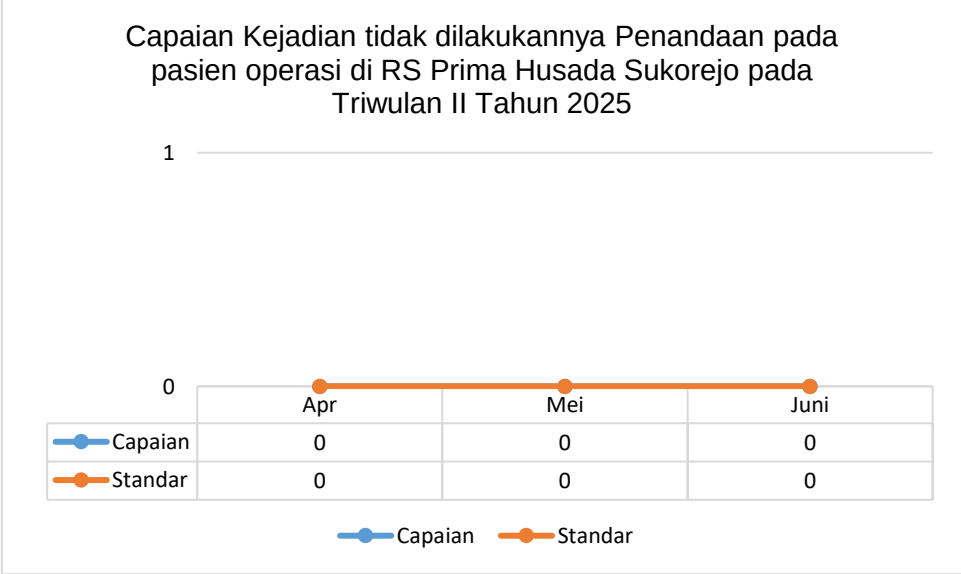


Gambar 3.18. Capaian Kepatuhan Pelaksanaan Surgical Sfety Checklist di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, kepatuhan pelaksanaan Surgical Safety Checklist (SSC) mencapai angka 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur keselamatan pasien pra, saat, dan pasca operasi telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai standar WHO.

e. Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi

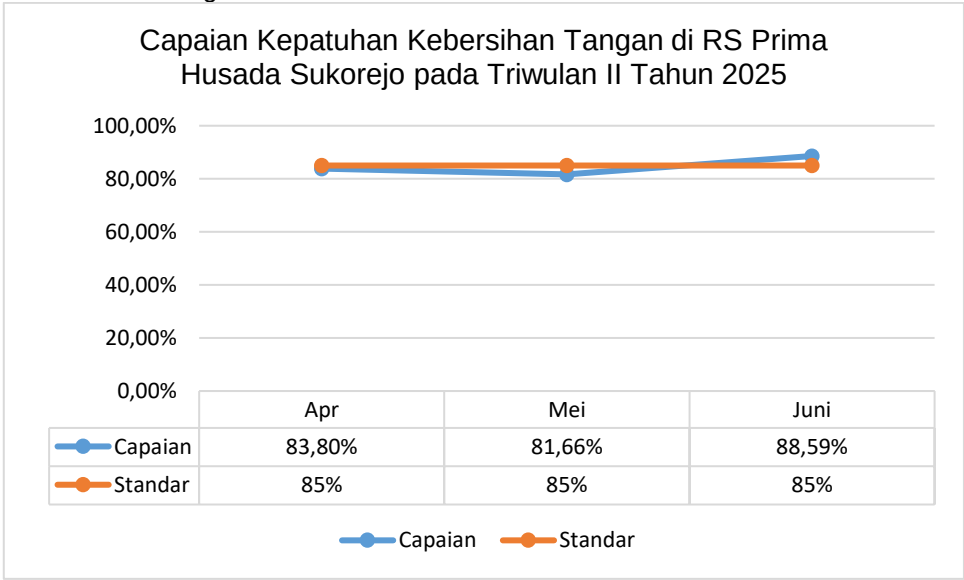


Gambar 3.19. Capaian Kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadian tidak dilakukannya Penandaan pada pasien operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 mencapai target 0 kejadian. Angka kejadian tercatat nol (0) dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

f. Kebersihan Tangan



Gambar 3.20. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II (April–Juni), diperoleh rata-rata sebesar 84,68%. Pada bulan April, tingkat kepatuhan mencapai 83,80%, kemudian menurun menjadi 81,66% di bulan Mei, dan meningkat signifikan menjadi 88,59% di bulan Juni. Meskipun nilai masih berada di atas 80%, capaian belum memenuhi standar ideal kepatuhan kebersihan tangan WHO yaitu $\geq 85\%$. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih menjadi tantangan, dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap praktik kebersihan tangan di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Triwulan II Tahun 2025

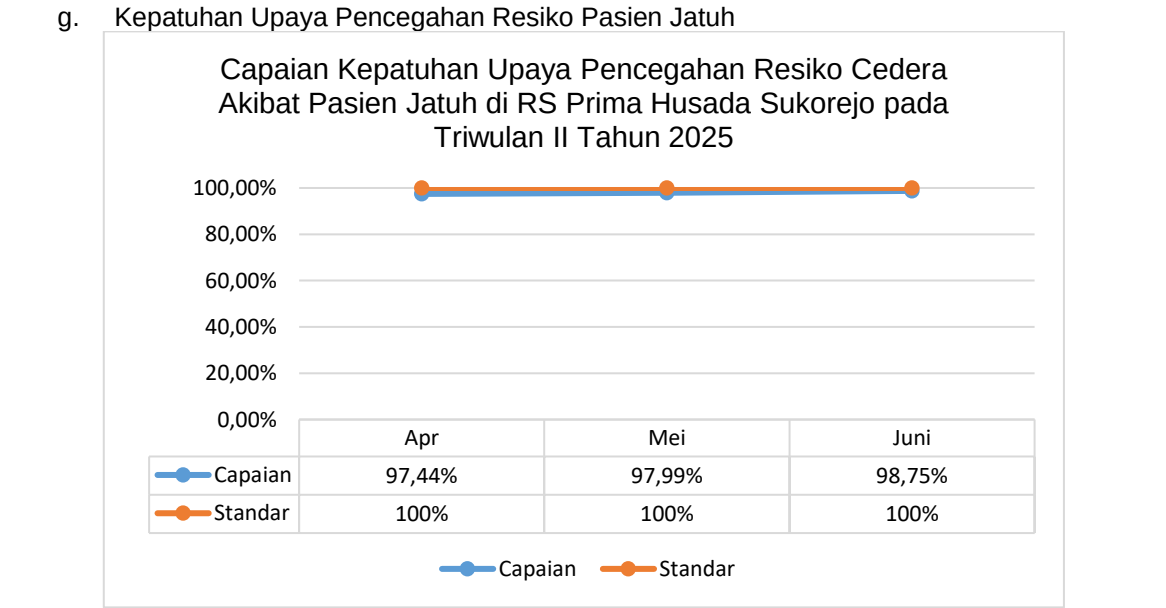
Proble m	Kepatuhan kebersihan tangan pada Triwulan II 2025 hanya mencapai 84,68%, belum mencapai target $\geq 85\%$.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Masalah yang ditemukan: a. Tingkat kepatuhan kebersihan tangan tenaga kesehatan belum mencapai target $\geq 85\%$, dengan rata-rata kepatuhan saat ini sebesar 84,68%. b. Masih ditemukan staf yang belum konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai 5 Momen WHO. c. Beberapa unit menunjukkan kepatuhan di bawah 85%, terutama saat jam sibuk atau malam hari. 2. Tujuan: a. Menstabilkan dan mempertahankan kepatuhan $\geq 85\%$ secara konsisten selama Triwulan III (Juli–September 2025). b. Membentuk perilaku otomatis kebersihan tangan di semua momen

	pelayanan 3. Rencana Aksi: - Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen
Do	- IPCN/IPCLN melakukan observasi acak langsung dan memberi umpan balik real time minimal 3 kali/minggu - Kepala unit melakukan briefing singkat tentang kepatuhan hand hygiene setiap awal shift. - Memberikan apresiasi mingguan kepada tenaga kesehatan/unit dengan kepatuhan tertinggi.
Study	- Hasil data Kepatuhan kebersihan tangan Triwulan II 2025 yaitu 84,68% - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah IRNA 3A sebesar 84,68%. - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 90,43% walaupun belum mencapai standar - Staff tidak mempraktekkan Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 <i>Moments of Hand Hygiene</i> dari WHO - Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan - Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40% - Sebelum Tindakan aseptik sebesar 49,07% - Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37% - Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88% - Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53%
Action	- Melakukan audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan coaching langsung di tempat (<i>bedside coaching</i>). - Melibatkan kepala unit sebagai role model, dengan pelaporan mingguan kepada manajemen. - Memberikan reward pada staff atau unit yang patuh dalam menjalankan kepatuhan kebersihan cuci tangan dan 5 momen

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Audit observasional terfokus per unit dengan pendekatan bedside coaching	Mengetahui secara langsung tingkat kepatuhan petugas terhadap 5 momen kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	- Observasi langsung oleh IPCN/IPCLN - Feedback real-time di tempat - Dokumentasi hasil audit untuk evaluasi	IPCN/IPCLN	1 kali/minggu/unit (Juli–Sept 2025)
2	Melibatkan kepala unit sebagai role model dalam pelaksanaan kebersihan tangan	Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan unit dalam budaya keselamatan pasien	Kepala ruang/unit pelayanan	- Kepala unit memberikan briefing awal shift tentang hand hygiene - Melakukan contoh perilaku langsung - Melaporkan kepatuhan tim tiap	Kepala Unit, Jajaran Manajemen	Briefing harian & laporan mingguan

				minggu ke manajemen		
3	Memberikan reward kepada staf/unit yang memiliki tingkat kepatuhan terbaik	Memberikan motivasi dan memperkuat budaya positif terhadap kepatuhan kebersihan tangan	Seluruh tenaga kesehatan di masing-masing unit	Penilaian berdasarkan hasil audit IPC - Pengumuman mingguan/bulanan untuk staf/unit terbaik - Pemberian piagam/apresiasi kecil sebagai motivasi	Tim PPI, Manajemen Mutu, SDM	Reward diberikan tiap akhir bulan (Juli–Des 2025)



Gambar 3.12. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Terdapat tren peningkatan capaian dari bulan ke bulan, yaitu dari 97,44% (April) menjadi 98,75% (Juni). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kepatuhan secara bertahap selama triwulan berjalan.

Tabel 3.22 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2025

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Triwulan II Tahun 2025adalah 98,06%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Masalah :

	1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Meskipun telah dilakukan pelatihan di unit umum pada bulan Juni 2025, belum seluruh petugas di unit pelayanan dan penunjang terpapar materi. Tujuan : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh hingga mencapai standar minimal 100%. Rencana Aksi : 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrining awal resiko jatuh pasien 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi skrining ulang pasien indikasi resiko jatuh di rawat inap 3. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian kepatuhan pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh masih dibawah standar yakni 98,06% 2. Asuhan skrining risiko jatuh tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti tidak adanya pemasangan tanda risiko jatuh pada alat bantu mobilisasi pasien (misalnya kursi roda). 3. Hand rail di tempat tidur pasien terpasang disebelah sisi, yang seharusnya menjadi alat bantu penting untuk mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur. 4. Tidak tertempelnya stiker penanda risiko jatuh di tempat tidur pasien 5. Kurangnya edukasi kepada pasien yang memiliki risiko jatuh, yang merupakan langkah penting dalam melibatkan pasien dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Triwulan II Tahun 2025 belum sesuai standar yakni 98,06% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang di Bulan Juli 2025 2. Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh yang mudah dipahami. 3. Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien. 4. Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentasi.

Tabel 3.23 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Memberikan pelatihan PMKP yang mencakup risiko jatuh ke seluruh petugas pelayanan dan penunjang	Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan staf dalam pencegahan risiko jatuh	Seluruh petugas pelayanan dan penunjang (perawat, dokter, lab, radiologi, farmasi, rehab medik, dll)	Pelatihan klasikal dan simulasi lapangan terkait skrining dan tindakan pencegahan risiko jatuh	Komite PMKP, PJ SKP, SDM & Kepala Ruang	Juli
2	Menyusun ulang SPO singkat dan form skrining risiko jatuh	Menyederhana kan panduan agar mudah diikuti dan konsisten	Seluruh petugas yang mengisi skrining risiko jatuh	Meninjau SPO lama dan menyusun ulang SPO singkat berbasis praktik	Komite PMKP, PJ SKP, SDM &	Juli

	yang mudah dipahami	diterapkan di semua unit		terbaik dan hasil audit	Kepala Ruang	
3	Memasang reminder visual tentang risiko jatuh di setiap tempat tidur pasien	Meningkatkan kesadaran petugas dan keluarga pasien tentang pencegahan risiko jatuh	Seluruh pasien rawat inap dan petugas di ruang perawatan	Pemasangan stiker/peringatan visual pada dinding/tempat tidur pasien dengan risiko jatuh	Kepala Unit	Juli
4	Menyiapkan label risiko jatuh (gelang dan tanda di tempat tidur) serta mengevaluasi kelengkapan dokumentas	Meningkatkan identifikasi pasien risiko tinggi dan memastikan dokumentasi lengkap	Pasien dengan risiko jatuh dan petugas yang melakukan penilaian risiko	Distribusi label risiko jatuh & audit checklist kelengkapan form risiko jatuh	Kepala Unit	Juli

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

a. Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB



Gambar 3.22. Capaian Ketepatan Pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

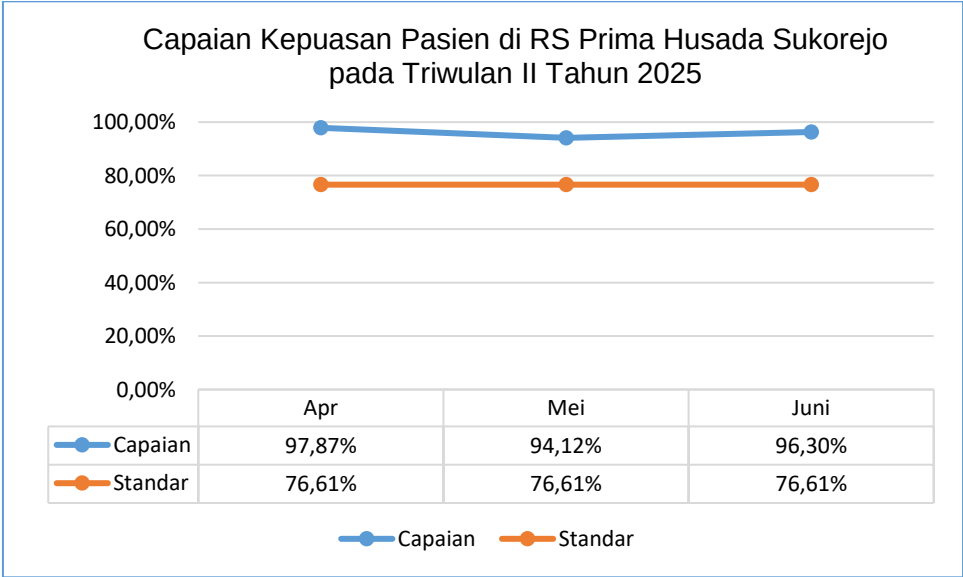
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemberian MgSO4 pada Pasien PEB di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 yakni mencapai 100%.

- b. Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS
- c. Pasien dengan Dengue yang Mendapatkan Pemantauan dan Intervensi Tepat Waktu untuk Mencegah Komplikasi Berat (Seperti Shock atau Perdarahan) dalam 24 Jam Pertama Setelah Diagnosis
- d. Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium
- e. Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan
- f. Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol

- g. Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%
- h. Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)
- i. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor
- j. Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis

3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS

a. Kepuasan Pasien



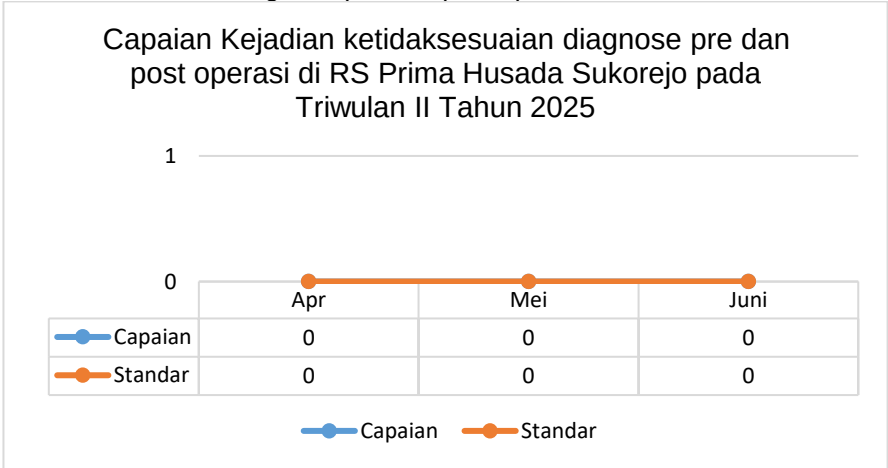
Gambar 3.32. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 96,10%. Angka tersebut sudah mencapai target 76,61%.

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

a. Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi

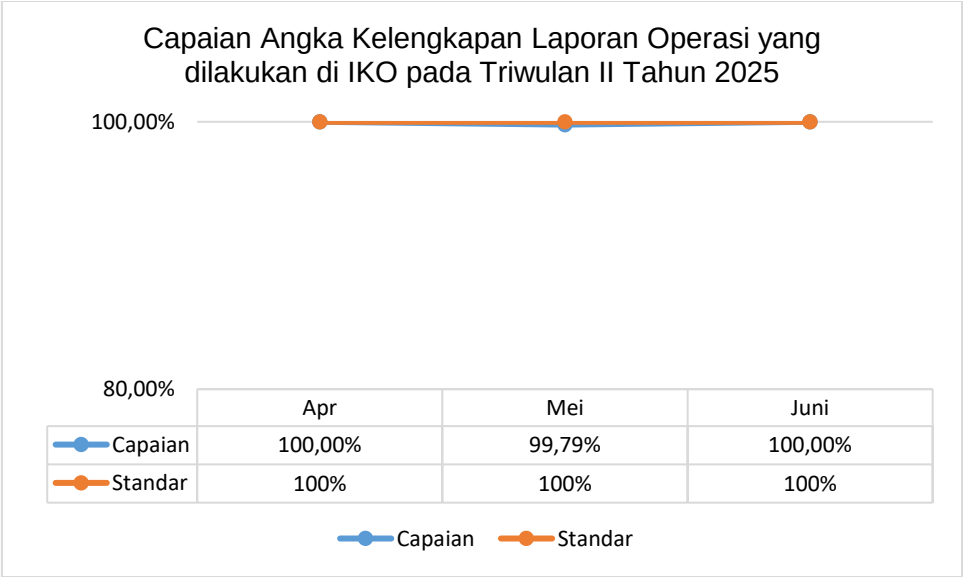


Gambar 3.33. Capaian Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian kejadian ketidaksesuaian diagnose pre & post operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Angka tersebut sudah mencapai target 0 kejadian.

b. Angka Kelengkapan laporan Operasi yang dilakukan di IKO

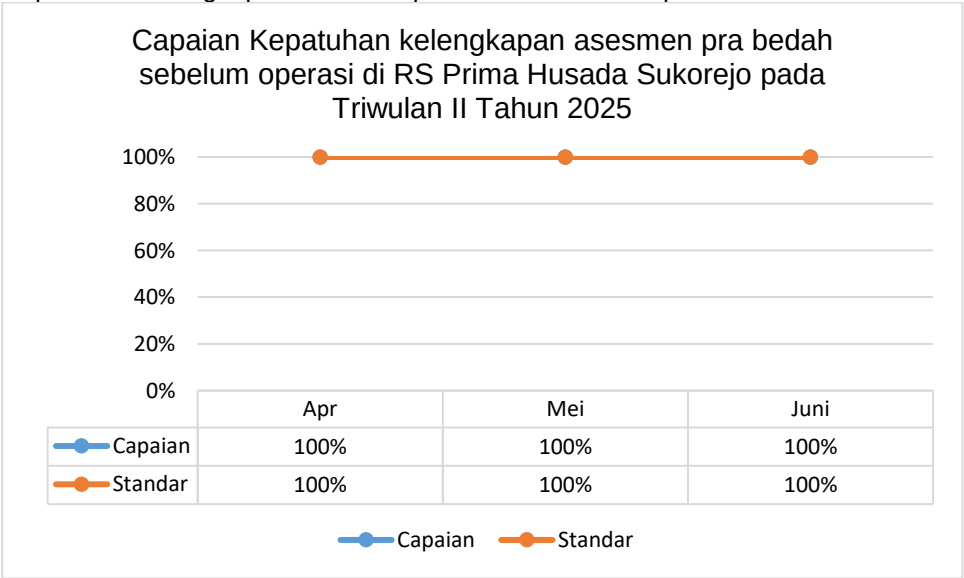


Gambar 3.34. Capaian Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang dilakukan di IKO di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 99,93% belum sesuai standar 100%.

c. Kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

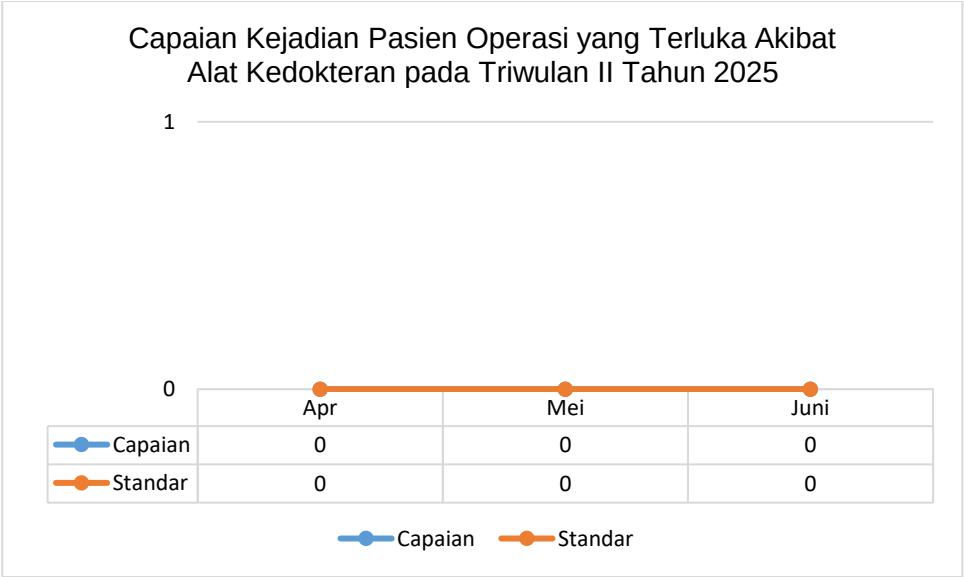


Gambar 3.35. Capaian Kepatuhan Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian kepatuhan kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa prosedur asesmen pra bedah sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin yang terstandarisasi di ruang tindakan/pre-operatif.

- 5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko
 - a. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran

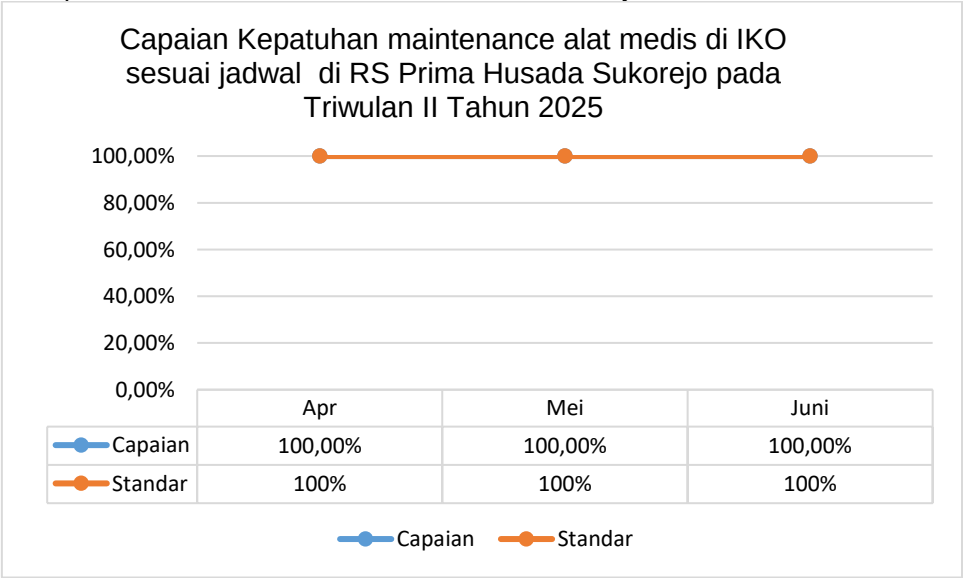


Gambar 3.36. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Bulan Triwulan II Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Pada bulan Maret 2025, telah dilakukan pergantian alat kedokteran, khususnya harum pen. Dampak positifnya pada Bulan April dan Triwulan II Tahun 2025 yakni menurunnya risiko cedera pada pasien operasi, dan meningkatkan kinerja tim bedah dan sterilisasi karena alat sudah memenuhi standar.

b. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal



Gambar 3.37. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.24 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Triwulan II Tahun 2025

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	82,35%	80,49%	94,59%	≥ 85 %	85,81%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	95,74%	92,16%	92,59%	≥ 76,61 %	98,67%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	97,33%	88,39%	98,67%	100%	94,80%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi yang dimusnahkan
3	Pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kematian pasien< 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	13/194 5	20/1921	24/120 0	≤ dua per seribu	1,24%	PDSA
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	96,00%	89,03%	88,39%	100%	91,14%	PDSA
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	96,67%	96,01%	97,33%	100%	96,67%	PDSA
5	Kelengkapan pengisian LOP	97,33%	89,68%	87,74%	100%	91,58%	PDSA
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	93,75%	90,32%	90%	100%	91,36%	PDSA
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang	90,32%	0,9%	0,9%	100%	30,71%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit						
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	90,32%	90,32%	90,32 %	100%	90,32%	PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.25 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,40%	86,96%	79,07 %	≥ 85 %	83,48%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	58,33%	-	67,83 %	100%	63,08%	PDSA
4	Kepuasan pasien	-	-	-	≥ 76,61%	-	Belum diisi
5	Waktu tunggu rawat jalan	74,78%	70,14%	79,70 %	≥80%	74,87%	PDSA
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan	-	-	-	≤5%	-	Belum diisi
2	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	
3	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	-	-	-	≥ 70%	-	
4	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)	100%	100%	100%	≥ 95%	100%	Dipertahankan
5	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
6	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah				≥ 75 %		

	<140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis						
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan $\geq$ 30 menit	9,98%	9,68%	14,00 %	0%	11,22%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kelengkapan Form E-RM PRMRJ Pasien	100%	95,87%	100%	100%	98,62%	PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.26 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	94,55%	94,55%	96,19%	100%	95,10%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	77,91%	69,03%	86,67%	≥ 85 %	77,87%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	93,64%	95,45%	96,19%	100%	95,09%	PDSA
4	Kepuasan pasien	85,71%	80%	100%	≥ 76,61 %	88,57%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	87,27%	84,55%	76,19%	≥ 80%	82,67%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi	91,38%	94,37%	100%	100%	95,25%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	efektif menggunakan SBAR						
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	25%	33,33%	0%	≥ 70%	19,44%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg				≥ 75 %		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis						
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,82%	1,33%	0,73%	≤ 0,24 %	1,29%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	6	3	5	0 kejadian	5 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	3	0	0	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	96,36%	94,55%	100%	100%	96,97%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	93,64%	95,45%	100%	100%	96,36%	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.27 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,33%	99,35%	99,33%	100%	99,34%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	77,91%	73,12%	80,85%	≥ 85 %	77,29%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	95,33%	95,48%	95,33%	100%	95,38%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	-	≥ 76,61 %	100%	Bulan Juni tidak ada pasien yang mengisi Barcode Kepuasan Pasien
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	68,67%	78,71%	66,00%	≥ 80%	71,13%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif	92,67%	93,55%	94,00%	100%	93,41%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	menggunakan SBAR						
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		
6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%		5%	0%	≥ 70%	2,50%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	1,40%	0,24%	0,25%	≤ 0,24 %	0,63%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	90,67%	91,61%	94,00%	100%	92,09%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	91,33%	92,90%	92,00%	100%	92,08%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.28 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	99,33%	98,06%	98,67%	100%	98,69%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	82,46%	85,11%	95,83%	≥ 85 %	87,80%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,67%	96,77%	98,00%	100%	97,81%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	92,86%	100%	≥ 76,61 %	97,62%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	94,00%	91,29%	97,33%	≥ 80%	94,21%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	95,15%	100%	-	100%	97,58%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	96,13%	97,42%	99,33%	100%	97,63%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat				≥ 90%		

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	(seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.						
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				$\geq 95\%$		
5	Kepatuhan Penanganan Bronchopneumonia sesuai dengan Kriteria Klaim BPJS				100%		Dipertahankan
6	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c $<7\%$				$\geq 70\%$		
7	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				$\geq 95\%$		
8	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		
9	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah $<140/90$ mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				$\geq 75\%$		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0,59%	$\leq 0,24\%$	0,20%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	4 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 Jam	98%	96,77%	98,67%	100%	97,81%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.29 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,00%	99,35%	97,33%	100%	98,23%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	86,96%	85,03%	71,05%	≥ 85 %	81,01%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,67%	90,32%	95,33%	100%	94,77%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	78,26%	87,50%	≥ 76,61 %	88,59%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	35,33%	48,39%	53,33%	≥ 80%	45,68%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	100%	-	-	≥ 80%	100%	Tidak ada diagnosa tunggal
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,00%	98,71%	93,33%	100%	96,68%	PDSA
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-		100%		Tidak ada obat sisa anestesi
3	Pasien dengan dengue yang mendapatkan pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk mencegah komplikasi berat (seperti shock atau perdarahan) dalam 24 jam pertama setelah diagnosis.				≥ 90%		
4	Pasien dengan demam tifoid yang menerima terapi antibiotik yang sesuai (misalnya, ceftriaxone, azithromycin) dalam waktu ≤ 24 jam setelah diagnosis klinis atau konfirmasi laboratorium				≥ 95%		
5	Pasien CVA infark yang mengalami kekambuhan dalam 6 bulan setelah pengobatan				≤5%		

6	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol				≥ 95%		
7	Pasien diabetes mellitus yang mencapai target HbA1c <7%	33,33%	0%	88,89%	≥ 70%	40,74%	PDSA
8	Kepatuhan pasien HIV terhadap pengobatan Antiretroviral (ART)				≥ 95%		
9	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				≥ 90 %		
10	Pasien hipertensi yang mencapai tekanan darah <140/90 mmHg dalam 3 bulan terakhir, sesuai panduan klinis				≥ 75 %		
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,37%	1,36%	1,01%	≤ 0.24 %	0,91%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	79,33%	42,58%	75,33%	100%	65,75%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	96,67%	98,71%	98,00%	100%	97,79%	PDSA

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.30 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	75%	46,15%	-	≥ 85 %	61%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	resiko pasien jatuh						
4	Penundaan operasi elektif $\geq$ 60 menit	4,52%	1,37%	3,84%	$\leq 5\%$	3,24%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	100%	-	-	$\geq 76,61\%$	100%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	0%	100%	0%	100%	33,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	100%	100%		Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian		Dipertahankan
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	-	-	-	100%		Tidak ada pemberian MgSO4 di Ruang IKO
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor				$\geq 90\%$		Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian		Dipertahankan
6	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	99,79%	100%	100%		PDSA
7	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)				100%		Belum diisi
2.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari				100%		Belum diisi
3.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
4.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada sisa obat anestesi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	≤ 6 %	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.32 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	93,57%	96,13%	97,84%	100%	95,85%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	86,67%	92,47%	94,00%	≥ 85 %	91,05%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	91,67%	100%	100%	> 80%	97,22%	Dipertahankan
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	88,57%	88,99%	92,73%	≥ 80%	90,10%	Dipertahankan
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	98,44%	98,84%	98,75%	≥ 80%	98,68%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	yang disebabkan oleh Eklampsia						
7	Kepatuhan Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala III segera setelah bayi lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian korioamnionitis pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini prematur	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kepatuhan pemberian antibiotika profilaksis sebelum operasi SC < 1 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
11	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
13	Kepatuhan Pemeriksaan DJJ saat kala II	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.34 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,07%	100%	100%	99,69%	PDSA
2	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	100%	85,71%	100%	> 80%	95,24%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61 %	-	Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa
3	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							

1	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	-	-	-	100%	-	Tidak ada pasien HPP di Ponék
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponék yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan
3	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%	dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,65%	100%	100%	100%	99,55%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,79%	93,55%	96,81%	≥ 85%	93,05%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	60,81%	65,82%	93,41%	≥ 80%	73,35%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	≥ 80%	-	Tidak ada pasien dengan Diagnosa tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	-	100%	≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	2 kejadian	8 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit						
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	92,31%	100%	80%	100%	90,77%	PDSA
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

11. ICU

A. ICU

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,83%	93,10 %	100%	96,98%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	75%	100%	65%	≥ 85%	80%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	53,57%	50%	68,97 %	≥ 80%	57,51%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	45,45%	100%	100%	100%	81,82%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat sisa anestesi
3	Kepatuhan pengobatan kanker payudara yang sesuai dengan protokol	-	-	-	≥ 95%	-	Tidak ada pasien ca mammae
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	≤ 3 %	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.37 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Triwulan II Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	-	-	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	-	-	100%	≥ 85%	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	-	-	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	-	-	50%	≥ 80%	50%	PDSA (2 Pasien)
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	-	-	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan penanganan bronchopneumoni a sesuai dengan kriteria klaim BPJS	-	-	-	100%	-	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	-	-	50%	≥ 80%	50%	PDSA
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	-	-	100%	≥ 95%	100%	Dipertahankan

12. RADIOLOGI

Tabel 3.38 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	77,78%	100%	100%	≥ 85%	92,59%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	-			≥ 76,61%		Belum diisi
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	96%	94,84%	90,32 %	100%	93,72%	PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

13. LABORATORIUM

Tabel 3.39 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,51%	-	-	≥ 85%	29,50%	PDSA (Mei dan Juni tidak dilakukan pengukuran)
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	84,62%	-	-	100%	28,21%	PDSA (Mei dan Juni tidak dilakukan pengukuran)
4	Kepuasan pasien				≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 120 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	0,05%	0%	0%	0,02%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan form permintaan laboratorium	5,02%	5,25%	5,98%	0%	5,42%	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	setiap pelayanan transfusi						
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	0%	0%	< 0,01%	0%	Dipertahankan
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.40 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,44%	86,96%	79,07%	≥ 85%	83,49%	PDSA
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	-	-	-	≥ 76,61%	-	Belum ada pasien yang scan barcode
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,10%	87,36%	100%	≥ 85%	91,82%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	97,87%	94,12%	96,30 %	≥ 76,61 %	96,10%	Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi	-	-	-	100%	-	Tidak ada obat yang dimusnahkan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	83,85%	81,67%	88,00 %	100%	84,51%	PDSA
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	69,23%	75,83%	72,80 %	100%	72,62%	PDSA
3	Kejadian kesalahan pernberian obat	0 Kejadian	5 Kejadian	2 Kejadian	0 kejadian	2 Kejadian	PDSA (kesalahan obat di rawat inap)
4	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

16. GIZI

Tabel 3.42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,72%	80,65%	96,30%	≥ 85%	87,22%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	80,65%	65,22%	100%	81,96%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥ 76,61%	96,10%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	≥ 90 %	100%	Dipertahankan
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	19%			≤ 20 %	19%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	pengisian asuhan gizi pasien rawat inap						
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	100%	0%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.43 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30 %	76,61%	96,10%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS							
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	91,74%	95,87%	94,83 %	100 %	94,15%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	53,97%	42,24%	30,43 %	100 %	42,21%	PDSA
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	6 kejadian	11 kejadian	9 kejadian	0 kejadian	9 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	63%	57%	57%	100%	59%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	28,13%	24,27%	28,71 %	0%	27,04%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,18%	96,84%	96,76 %	100%	96,93%	PDSA
8	Kelengkapan General Consent	98,58%	98,51%	99,25 %	100%	98,78%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	4,03%	3,87%	15,33 %	100%	7,74%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.44 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			

1.	Baku mutu limbah cair	a. BOD = 8,53 mg/l b. COD = 35,70 mg/l c. TSS = 5,72 mg/l d. PH = 7,20	a.BOD = 14,75 mg/l b. COD = 41,10 mg/l c. TSS = 9,88 mg/l d. PH = 7,30	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a.BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD = mg/l b. COD = mg/l c. TSS = mg/l d. PH =	Dipertahankan
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	48,18%	61,82%	61,82%	100%	61,82%	1 Tahun
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

19. SDM

Tabel 3.45 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	62,96%	62,96%	60,74%	100 %	62,22%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	≥ 60 %	0%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	0,86%	1,52%	1,30%	≤10% / bulan	1,23%	Dipertahankan
4.	Kejadian SIP staf habis masa berlaku	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	8,62%	10,85%	12,99%	0%	10,82%	PDSA
6.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPG D/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	65,02%	65,02%	65,02%	100%	65,02%	PDSA
7.	Kepuasan karyawan	69%			≥ 80 %	69%	Semesteran PDSA
8.	Respon time penanganan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

	masalah karyawan ≤ 24 jam						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.46 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	97,06%	100%	100%	99,02%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.47 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	100%	100%	≥80%	100%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

22. PEMULASARAAN JENAZAH

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.49 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
ATEM							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100%	100%	≤ 80%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat	-	-	-	100%	-	Tidak ada alat medis kritikal

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	medis critical $\leq$ 15 menit						
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal				100%		Alat di Kalibrasi di Bulan Agustus
IPSRs							
1.	Waktu tanggap kerusakan alat non medis $\leq$ 15 menit	100%	70,59%	43,35 %	100%	71,31%	PDSA
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset $\leq$ 10 detik	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)				100%		Belum diisi

24. LAUNDRY

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan penggunaan APD	70%	0%	0%	100%	23,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kejadian linen yang hilang	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	2 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat – alat pencucian linen	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar 135 derajat (merubah pedoman di 2025)	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	90,48%	95,61%	97,19%	100%	94,43%	PDSA
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse:	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Swab Instrumen Negative

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
	1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR						
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	88,10%	95,20%	96,48%	100%	93,26%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	86,51%	95,93%	98,24%	100%	93,56%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.52 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	0%	0%	100%	100%	33,33%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit							
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100%	75%	100%	100%	91,67%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

27. KEAMANAN

Tabel 3.53 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	0 kejadian	1 kejadian	3 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	98,89%	100%	99,63%	PDSA
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	566 kejadian	741 kejadian	642 kejadian	0 kejadian	650 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	100%	98,71%	99,89%	100%	99,53%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan penggunaan id card staff di area rumah sakit	67,56%	83,23%	88,44%	100%	79,74%	PDSA

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.54 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	93,20%	96,09%	93,10%	100%	94,13%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka kepatuhan pengajuan pengadaan ke PT ≤ (lihat SPO)	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.55 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80%	81,66%	88,59%	≥ 85%	84,68%	PDSA
2.	Kepatuhan APD	97,92%	98,07%	93,80%	≥ 100%	96,60%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Komite PPI							
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	82,39%	96,86%	90%	60 %	89,75%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	6,33%	75,85%	69,66%	75 %	50,61%	PDSA
3.	Angka infeksi daerah operasi	0%	0%	0%	≤ 1,5%	0%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	95%	100%	88%	100%	94,33%	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	79,50%	72,75%	86,09%	100%	79,45%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	97,31%	84,42%	90,91%	100%	90,88%	PDSA
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	56,67%	75,85%	78,54%	100%	70,35%	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	11,90%	100%	16,67%	100%	42,86%	PDSA
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	50%	44,12%	50%	100%	48,04%	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Bulan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	50,00%	55,36%	64,29%	100%	56,55%	PDSA
2.	Kepatuhan petugas dalam pengisian form edukasi kolaborasi	53,93%	86,98%	100%	100%	80,30%	PDSA
3.	Ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi	52,50%	97,14%	58,60%	100%	69,41%	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	50%	55,36%	64,29%	100%	56,55%	PDSA

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR (CPPT, HO, SBAR)	96,88%	97,67%	100%	100%	98,18%	PDSA
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	41,67%	100%	100%	100%	80,56%	PDSA

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.57 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	kepatuhan DPJP dalam penegakan diagnosa sesuai dengan ketentuan BPJS	95,03%	96,81%	97,24%	80%	96,36%	Dipertahankan
2.	kelengkapan berkas penunjang klaim pelayanan	94,81%	99,10%	99,76%	100%	97,89%	PDSA
3.	Kepatuhan petugas rawat inap terhadap penyeteroran rekam medis BPJS Kesehatan < 24jam	93,09%	96,42%	95,43%	100%	94,98%	PDSA
4.	kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	87,87%	90,12%	91,67%	100%	89,89%	PDSA
5.	Kejadian berkas pending klaim pasien BPJS	216 kejadian	188 kejadian	164 kejadian	0 kejadian	189 kejadian	PDSA

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepuasan Pasien MCU	100%	0%	0%	≥ 76,61%	33,33%	PDSA Mei, Juni tidak ada pasien MCU yang scan barcode
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0,03%	0,03%	0,03%	10% / tahun	0,03%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan	Standar	Keterangan
-----	-----------	-------	---------	------------

		April	Mei	Juni		Rata-rata	
1.	Respon time CSO <30 mnt (WA)	16,15%	12,09%	11,96%	100%	13,40%	PDSA
2.	Ketepatan perubahan jadwal dokter spesialis	-			100%		Adanya SE tentang Penyesuaian Kebijakan Sesuai HFIS Versi 6.0

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.60 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
Indikator Mutu Nasional							
1	Kepuasan Pasien	97,87%	94,12%	96,30%	≥ 76,61%	96,10%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP							
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

35. TB di IRJA

Tabel 3.61 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	-	-	100%	-	Belum diisi
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	100%	-	-	≥ 90%	-	Belum diisi

36. KEUANGAN

Tabel 3.62 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10 menit	0%	0%	0%	<5%	0%	Dipertahankan

3	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	0%	0%	0%	100%	0%	Dipertahankan
4	Jumlah piutang ≥ 60 hari				0%		Belum ada capaian

37. TIM HIV

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	100%	0%	0%	≥ 90%	33,33 %	PDSA

38. KB

Tabel 3.64 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	88,96%	100%	96,32%	PDSA
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	69,15%	7,20%	16,06%	50%	30,80%	PDSA
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%	100%	96,35%	100%	98,78%	PDSA
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	97,26%	100%	88,96%	30%	95,41%	Dipertahankan

39. STUNTING

Tabel 3.65 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	0%	0%	100%	100%	33%	PDSA
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3bulan sekali				100%		Triwulanan
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan

40. IT - SIM RS

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Triwulan II Tahun 2025

No .	Indikator	Bulan			Standar	Rata-rata	Keterangan
		April	Mei	Juni			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	66,67%	100%	91,67 %	PDSA
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	37,50%	11,54%	58,54%	100%	51,90 %	PDSA